SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi

MODÜL 4 · Üretken YZ ile Akademik Yazım ve Hasta Eğitimi

İstem Kütüphanesi

Kopyala · yapıştır · uyarla

Hemşirelik, ebelik ve beslenme öğretim üyeleri için 62 hazır istem: literatürden akademik yazıma, dersten hasta eğitimine. Derste ve sonrasında masanızda açık tutmanız için hazırlandı.

1	İstem yazmayı öğrenme ve iyileştirme	9 istem
2	Literatür tarama, özetleme ve veri çıkarma	10 istem
3	Akademik yazım	11 istem
4	Eğitim ve öğretim	8 istem
5	Hasta eğitimi ve broşür kişiselleştirme	10 istem
6	Klinik dokümantasyon (yalnızca kurum onaylı araçla)	6 istem
7	Doğrulama ve güvenlik istemleri	8 istem

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Eğitmen
Ali AKDAĞLI

2026

Araç adları 2026 itibarıyla örnektir; araçlar ve özellikleri hızla değişir. Bu kitapçıktaki örnek metinler (sentetik epikriz, kurgusal RKÇ özeti, diyabetik ayak broşürü) gerçek hasta veya çalışma içermez.

Bu kitapçık nasıl kullanılır?

Bu kitapçık okunmak için değil, **kullanılmak** için hazırlandı. Her istem bir karttır: gri kutudaki metni kopyalıyoruz, sohbet asistanına yapıştırıyoruz, köşeli parantezli alanları kendi işinize göre dolduruyoruz ve gönderiyoruz. Kartlar yedi kategoride toplanmıştır; İçindekiler bölümü aynı zamanda istem dizinidir.

■ Dört temel kural

1. **[DEĞİŞKEN] alanlarını dolduruyoruz.** Lacivert ve kalın yazılmış köşeli parantezler sizin dolduracağınız yerlerdir. "ör." ile başlayan kısımlar yalnızca örnektir; silip kendi bilginizi yazıyoruz. Doldurulmayan alanı YZ kendi varsayımıyla doldurur.
2. **Çıktı her zaman taslaktır.** YZ çok okumuş ama hiç hasta görmemiş, aşırı özgüvenli bir stajyer gibidir. Her çıktıyı okuyoruz, sayıları ve kaynakları doğruluyoruz; imza ve sorumluluk sizindir.
3. **Gerçek hasta veya katılımcı verisi yazmamanızı önemle rica ederiz.** Ad, T.C. kimlik, protokol no, tarih, oda no, fotoğraf ve nadir tanı-yer birleşimi de buna dahildir. Sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir (KVKK, 2025).
4. **Kurum onaylı araç yoksa yalnızca kişisel olmayan metin kullanıyoruz.** Kendi taslağınız, yayımlanmış bilgi, sentetik veya kurgusal örnekler (eğitimdeki ornekler/ klasörü) güvenlidir; epikriz, hemşire notu ve öğrenci kimliği içeren metinler değildir.

Bir kartın parçaları

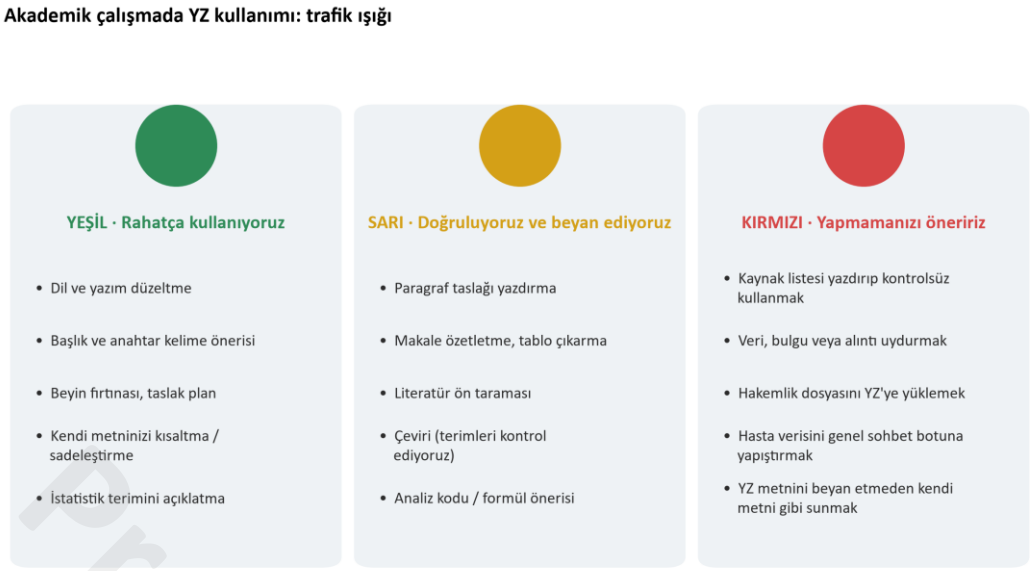
Parça	Ne anlatır?
Başlık ve numara	Kategori numarası ve kartın sırası (ör. 5.7). İçindekiler'de de aynı numarayla yer alır.
Trafik etiketi	Kartın risk düzeyi (aşağıdaki tablo). Yanında hangi araçla kullanılacağı yazar.
Ne işe yarar?	Kartın tek cümlelik amacı.
Gri kutu (istem)	Kopyalanacak metin. **[LACİVERT ALANLAR]** sizin dolduracağınız yerlerdir. **[KAYNAK]**, **[KONTROL ET]**, **[DOSYADA YOK]** gibi mercan renkli işaretleri ise YZ metne koyar; olduğu gibi bırakın. Üç tırnak ''' ... ''' arası, metninizi yapıştıracağınız yerdir ve YZ'ye metnin nerede başlayıp bittiğini gösterir.
▸ İpucu	Daha iyi sonuç için pratik öneri; çoğu zaman eğitimdeki sentetik örneklerle nasıl deneneceği.
▲ Dikkat	Bu istemin tipik riski: uydurma, anlam kayması, gizlilik veya hasta güvenliği.

Trafik ışığı etiketleri

Her kartın etiketi, Oturum 3'te kullandığımız trafik ışığının (Şekil 3.2) istem düzeyindeki karşılığıdır. Etiket istemin kendisini değil, **çıktıyı nasıl ele almanız gerektiğini** gösterir.

YEŞİL	Düşük risk · okuyoruz, uyarlıyoruz, kullanıyoruz	Örnek: Dil düzeltme, başlık önerisi, ders planı, teach-back soruları
SARI	Doğruluyoruz · sayı, kaynak ve klinik bilgiyi kontrol ediyoruz; gerekiyorsa beyan ediyoruz	Örnek: Literatür özeti, veri çıkarma, giriş taslağı, hasta broşürü
KIRMIZI	Yüksek risk · yalnızca kurum onaylı araç + anonim/sentetik veri + uzman onayı	Örnek: Epikrizden taburculuk metni, SBAR, anonimleştirme kontrolü, Arapça çeviri

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI



Şekil 3.2. *Akademik çalışmada YZ kullanımı: trafik ışığı. Yeşil rahatça kullanılır, sarı doğrulanır ve beyan edilir, kırmızı yapılmaz. Kitapçıktaki KIRMIZI etiketli istemler yalnızca belirtilen koşullar sağlandığında kullanılır.*

Kopyalarken ve kullanırken

- Gri kutunun içini fareyle seçip kopyalıyoruz (Ctrl+C). Word'den yapıştırırken biçim taşınırsa sohbet kutusuna Ctrl+Shift+V ile düz metin olarak yapıştırıyoruz.
- Aynı istemi "yeniden oluştur" ile birkaç kez çalıştırıyoruz: yanıtlar farklıysa, o konuda modelin tutarsız olduğunu gösterir.
- Araç adları (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, NotebookLM, Elicit, Consensus) **2026 itibarıyla örnektir**; menü adları ve sınırlar sık değişir. İstemler araçtan bağımsız yazılmıştır.
- Akademik bir çıktıda YZ kullandıysanız beyan ediyoruz (bkz. 3.11). Hasta materyalinde son onayı bir klinisyen verir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

5N1K: Tek sayfada iyi istem

İyi bir istem, iyi bir order gibidir. “Parasetamol ver” belirsiz bir orderdır. “Parasetamol 500 mg PO, ateş >38,5 °C ise, 6 saatte bir, günde en fazla 4 kez” ise net bir orderdır. İstemi de aynı netlikte, gazetecilerin 5N1K sorularıyla yazarız.



Şekil 1.9. *İyi bir istemin anatomisi: 5N1K. Kitapçıktaki tüm istemler bu altı öğeye göre yazılmıştır.*

Öğe	Sorduğu soru	İstemdeki kalıp	Order karşılığı
Kim? Rol ver	YZ kimin gözüyle yazsın?	“Sen deneyimli bir ... olarak çalış.”	Orderi uygulayacak yetkin kişi
Ne? Görevi söyle	Ne üretilecek?	“Görev: ... hazırla / listele / karşılaştır.”	İlacın adı
Neden? Amacı açıkla	Çıktı ne için kullanılacak?	“Amaç: ... böylece ...”	Endikasyon (ateş >38,5 °C ise)
Kime / Nerede? Bağlamı ver	Kim okuyacak, nerede kullanılacak?	“Kitle: 68 yaşında, ilkokul mezunu ...”	Hasta ve uygulama ortamı
Nasıl? Biçimi belirle	Hangi biçimde, hangi dille?	“Biçim: tablo; kısa cümleler; madde işaretleri.”	Doz, yol, sıklık (500 mg PO, 6 saatte bir)
Ne kadar / Ne yapma? Sınır koy	Uzunluk ne, neler yasak?	“En fazla 1 sayfa. Doz değiştirme; kaynak uydurma; emin değilsen [KONTROL ET].”	Üst sınır (günde en fazla 4 kez)

Kısa kontrol: İsteminizi gönderen siz değil de nöbeti devralan bir meslektaşınız olsaydı, ne istendiğini, kim için ve hangi sınırlar içinde istendiğini anlayabilir miydi? Anlayamıyorsa YZ de anlayamaz.

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

Altın kurallar

Kartların “Dikkat” satırları bu on kuralın tekrar eden hâlleridir. Kitapçığı açtığınızda önce bu sayfaya bakıyoruz.

1	**Hasta ve katılımcı verisi yazmamanızı öneririz.** Ad silmek yetmez; tarih, protokol no, nadir tanı ve yer birleşimi de kişiyi belirler. Kurum onaylı araç yoksa yalnızca kişisel olmayan veya sentetik metin.
2	**Her çıktı bir taslaktır.** YZ asistandır, imza sizindir. Okumadığınız, kontrol etmediğiniz metni kullanmamanızı öneririz.
3	**Kaynağı YZ'ye yazdırmıyoruz, [KAYNAK] koyduruyoruz.** Kaynakları veritabanında kendimiz buluyoruz ve açıp okuyoruz; uydurma kaynak oranı serbest modellerde yüksektir (Walters ve Wilder, 2023).
4	**Belgeye dayandırıyoruz.** Özetleme ve veri çıkarmada belgeyi veriyoruz, “yalnızca bu belgeye dayan” örneğin ve sayfa/tablo numarası istiyoruz.
5	**Her sayıyı orijinalle karşılaştırıyoruz.** n, %, GA, p, doz, saat ve eşik değerler en sık kayan bilgilerdir.
6	**5N1K ile yazıyoruz.** Rol, görev, amaç, kitle, biçim ve sınır: net bir order gibi.
7	**Yineliyoruz.** İlk yanıt son yanıt değildir: iste → oku → kontrol et → ölçülebilir geri bildirim ver.
8	**Gizli dosyaları yüklememenizi öneririz.** Hakemlik yaptığınız makale, sınav soru bankası ve yayımlanmamış başkasına ait metinler genel araçlara yüklenmez (ICMJE).
9	**Beyan ediyoruz.** Hangi aracı, hangi aşamada ve ne ölçüde kullandığınızı yazıyoruz. YZ yazar olamaz, kaynak olarak gösterilemez (ICMJE; YÖK, 2024).
10	**Hasta metninde puan yetmez.** Okunabilirliği ölçüyoruz (hedef Ateşman ≥70), ama klinik kontrol ve hastaya geri anlattırma (teach-back) olmadan dağıtmamanızı öneririz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

İçindekiler ve istem dizini

Bu kitapçık nasıl kullanılır? 2
Bir kartın parçaları 2
Trafik ışığı etiketleri 2
Kopyalarken ve kullanırken 3
5N1K: Tek sayfada iyi istem 4
Altın kurallar 5
1. İstem yazmayı öğrenme ve iyileştirme 7
1.1 5N1K iskelet istemi (genel şablon) 7
1.2 “Önce bana soru sor” istemi 7
1.3 İstemimi geliştir (istemi değerlendirtme) 8
1.4 Örnekle öğret (örnekli istem) 8
1.5 Önce plan, sonra metin (adım adım) 8
1.6 Aynı içerik, farklı kitle 9
1.7 Geri bildirimle düzelttirme (yinelemeli istem) 9
1.8 Yanıt biçimini sabitleme (tablo kalıbı) 9
1.9 Uzun belgeyi parça parça işleme 10
2. Literatür tarama, özetleme ve veri çıkarma 10
2.1 Araştırma fikrini PICO'ya dönüştürme 10
2.2 Eş anlamlılar ve MeSH önerileri 11
2.3 Boolean arama dizisi taslağı 11
2.4 Arama dizisini daraltma veya genişletme 12
2.5 Dahil etme ve dışlama kriterleri 12
2.6 Belgeye dayalı makale özeti 12
2.7 Çok makaleli karşılaştırma tablosu 13
2.8 Veri çıkarma tablosu (sayfa/tablo sütunlu) 13
2.9 Sınırlılık ve yanlılık avı (eleştirel okuma) 13
2.10 Aynı çalışmayı üç kitleye özetleme 14
3. Akademik yazım 14
3.1 Başlık önerileri 14
3.2 Yapılandırılmış özet 15
3.3 Giriş bölümü planı ([KAYNAK] yer tutuculu) 15
3.4 Yöntem bölümünü raporlama rehberine göre kontrol 16
3.5 Bulgular ile tablolar arasında tutarlılık kontrolü 16

PROF. DR. ALİ AKDAĞLI

3.6 Tartışma için karşı argüman (şeytanın avukatı) ... 17
3.7 Sınırlılıklar paragrafı ... 17
3.8 Dil düzeltme (anlamı koruyarak, değişiklikleri listeleyerek) ... 18
3.9 İngilizce çeviri ve terim kontrolü ... 18
3.10 Hakem yorumlarına yanıt mektubu ... 19
3.11 YZ kullanım beyanı yazdırma ... 19
4. Eğitim ve öğretim ... 20
4.1 Ders planı ... 20
4.2 Vaka senaryosu (hemşirelik, ebelik, beslenme) ... 21
4.3 OSCE istasyonu ... 21
4.4 Çoktan seçmeli soru ve çeldirici analizi ... 22
4.5 Rubrik (dereceli puanlama anahtarı) ... 22
4.6 Öğrenciye yapıcı geri bildirim ... 23
4.7 YZ'li ödev tasarımı (süreç odaklı) ... 23
4.8 Zor bir kavram için benzetme ve örnek ... 24
5. Hasta eğitimi ve broşür kişiselleştirme ... 24
5.1 Broşürü sadeleştirme (Ateşman ≥70 hedefli) ... 25
5.2 Profil 1: Yaşlı, ilkokul mezunu hasta ve yakını ... 25
5.3 Profil 2: Genç, dijital okur ... 26
5.4 Profil 3: İlk gebelik ... 26
5.5 Profil 4: Arapça konuşan hasta (anadil kontrolü zorunlu) ... 27
5.6 Profil 5: Görme kaybı olan hasta ... 27
5.7 “Ne zaman acile gelinir?” kutusu ... 28
5.8 Teach-back (geri anlattırma) soruları ... 28
5.9 Sık sorulan sorular (SSS) ... 29
5.10 Beslenme planını sade dile çevirme ... 29
6. Klinik dokümantasyon (yalnızca kurum onaylı araçla) ... 30
6.1 Epikrizden taburculuk eğitim metni (ilaç tablosu + “dosyada yoksa yazma”) ... 30
6.2 Taburculuk metnini epikrizle karşılaştırma (hata avı) ... 31
6.3 SBAR devir notu yapılandırma ... 31
6.4 Taburculuk kontrol listesi ... 32
6.5 Kendi taslağınızı hata için denetletme ... 32
6.6 Epikriz kısaltmalarını açma ve sade karşılık bulma ... 33
7. Doğrulama ve güvenlik istemleri ... 33
7.1 “Bu metindeki her iddiayı listele ve kaynak gerekenleri işaretle” ... 33

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

7.2 “Emin olmadığın yerleri [KONTROL ET] ile işaretle” 34
7.3 “Yanıtındaki varsayımları listele” 34
7.4 Anonimleştirme kontrol istemi 34
7.5 Kaynak listesini doğrulama tablosuna dönüştürme 35
7.6 Sayı ve istatistik eşleştirme 35
7.7 Uzman gözüyle öz eleştiri 35
7.8 Hasta metni güvenlik taraması 36
8. Kendi istem kütüphanenizi kuruyoruz 37
Boş kart şablonu 37
İstem kayıt tablosu 37
Kütüphanenizi büyütürken 37
Kaynakça 38

Prof. Dr. Alİ AKDAĞLI

1. İstem yazmayı öğrenme ve iyileştirme

Bu bölümdeki istemler belirli bir işi değil, **istem yazma becerisinin kendisini** geliştirir. İstem bir order gibidir: “Parasetamol ver” belirsizdir, dozu, yolu, endikasyonu ve sınırı yazılmış order nettir. Önce 1.1'deki 5N1K iskeletini kaydediyoruz; diğer bölümlerdeki istemlerin hepsi bu iskeletin uyarlanmış hâlidir.

1.1 5N1K iskelet istemi (genel şablon)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Her yeni iş için boşluklarını doldurup kullanacağınız ana şablondur.

> Rol: Sen bir **[ROL, ör. deneyimli diyabet eğitim hemşiresi / ebelik öğretim üyesi / klinik diyetisyen]** olarak çalışıyorsun.
> Görev: **[YAPILACAK İŞ, ör. bir taburculuk eğitim broşürü taslağı hazırla]**.
> Amaç: Bu metin **[AMAÇ, ör. hastanın evde insülinini güvenle yapabilmesi]** için kullanılacak.
> Kitle ve bağlam: **[KİM OKUYACAK, NEREDE KULLANILACAK, ör. 68 yaşında, ilkokul mezunu, yeni insülin başlanan hasta]**.
> Biçim: **[BİÇİM, ör. kısa cümleler, madde işaretleri, en sonda “Ne zaman acile gelinir?” kutusu]**.
> Sınırlar: En fazla **[UZUNLUK]**. **[YAPMAMASI GEREKENLER, ör. doz değiştirme, ilaç önerme, kaynak uydurma]**.
> Emin olmadığın bilgiyi yazdıktan sonra **[KONTROL ET]** etiketi koy.
> Başlamadan önce görevi anlamak için sorman gereken bir şey varsa önce sor.

▸ **İpucu:** Altı satırı doldurduktan sonra kendimize soruyoruz: Bu orderi alan bir meslektaşım ne yapacağını bilir miydi? Bilmiyorsa YZ de bilmez.

▲ **Dikkat:** Doldurulmadan bırakılan köşeli parantezleri YZ kendi varsayımıyla doldurur. Göndermeden önce tüm [ ] alanlarını kontrol ediyoruz.

1.2 “Önce bana soru sor” istemi

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Ne istediğinizi henüz netleştirmediğinizde YZ'nin sizi sorularla yönlendirmesini sağlar.

> **[GÖREV, ör. 3. sınıf hemşirelik öğrencileri için preeklampsi vaka senaryosu]** hazırlamak istiyorum.
> Hemen yazmaya başlama. Önce iyi bir sonuç için bilmen gereken bilgileri bana sor.
> – En fazla 7 soru sor; soruları numaralandır ve her birinin yanına neden sorduğunu yarım cümleyle yaz.
> – Seçenekli sorulabilecek soruları (a / b / c) seçenekleriyle sor.
> – Ben yanıtlayınca yanıtlarımı 5N1K başlıklarıyla (rol, görev, amaç, kitle, biçim, sınırlar) özetle ve onayımı al.
> – Onaylarsam metni yaz.

▸ **İpucu:** Yanıtlarınızı kısa tutuyoruz. “Bilmiyorum, sen öner” demek de geçerli bir yanıttır, ama YZ'nin önerisini mutlaka gözden geçiriyoruz.

▲ **Dikkat:** Sorular sizi vaka ayrıntısı vermeye yönlendirebilir. Gerçek hasta veya öğrenci bilgisi değil, kurgusal bilgi veriyoruz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

1.3 İstemimi geliştir (istemi değerlendirtme)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Yazdığınız istemi 5N1K'ya göre puanlatır ve güçlendirilmiş bir sürüm önerir.

> Aşağıda bir YZ asistanına vermeyi düşündüğüm istem var. Bu istemi ÇALIŞTIRMA, yalnızca değerlendir.
> 1. 5N1K ölçütlerinin her birini (Kim/rol, Ne/görev, Neden/amaç, Kime-Nerede/bağlam, Nasıl/biçim, Ne kadar-Ne yapma/sınırlar) "var / kısmen / yok" olarak bir tabloda değerlendir.
> 2. Belirsiz kalan ve farklı yorumlanabilecek ifadeleri listele.
> 3. Geliştirilmiş bir sürüm yaz. Bilmediğin bilgileri uydurma; onları **[DOLDURULACAK: ...]** biçiminde boş bırak.
> 4. Neyi neden değiştirdiğini en fazla 5 maddede açıkla.
> İstemim: '''**[İSTEMİNİZ]**'''

▸ **İpucu:** Eğitimdeki zayıf istemle deneyin: "Diyabetik ayak hakkında broşür yaz." Sonucu Şekil 1.10'daki güçlü istemle karşılaştırıyoruz.

▲ **Dikkat:** Daha uzun istem her zaman daha iyi değildir. Gereksiz kısıt eklendiyse siliyoruz; [DOLDURULACAK] alanlarını biz dolduruyoruz.

1.4 Örnekle öğret (örnekli istem)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? İstediğiniz üslubu ve biçimi bir-iki örnekle göstererek YZ'nin aynı kalıpta üretmesini sağlar.

> Rol: **[BÖLÜM]** eğitiminde ölçme-değerlendirme deneyimi olan bir öğretim üyesi olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki örneklerle aynı biçimde ve aynı zorlukta **[SAYI]** yeni **[ÜRÜN TÜRÜ, ör. kısa vaka sorusu]** yaz.
> Örnek 1: '''**[KENDİ ÖRNEĞİNİZ 1]**'''
> Örnek 2: '''**[KENDİ ÖRNEĞİNİZ 2]**'''
> Kurallar:
> – Örneklerdeki uzunluğu, yapıyı ve dil düzeyini koru; içeriği kopyalama, yalnızca biçimi taklit et.
> – Konuları şu listeden seç: **[KONU LİSTESİ]**.
> – Her yeni ürünün altına hangi konuyu ele aldığını bir satırla yaz.

▸ **İpucu:** İki-üç iyi örnek çoğu iş için yeterlidir. Örnekler birbirinden farklıysa YZ'nin hangi özelliği taklit edeceğini açıkça yazıyoruz.

▲ **Dikkat:** Örneklerinizdeki hatalar da kopyalanır. Yayımlanmış veya kullanımda olan sınav sorularını genel araçlara örnek olarak vermemenizi öneririz.

1.5 Önce plan, sonra metin (adım adım)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Uzun bir metni yazdırmadan önce ana hattı onaylamanızı sağlar; boşa yazımı ve atlanan bölümleri azaltır.

> Görev: **[METİN TÜRÜ VE KONUSU, ör. "Gebelikte demir eksikliği anemisi" konulu 2 saatlik ders notu]** hazırlayacağız. Bu işi adım adım yapıyoruz:
> Adım 1 – Yalnızca bir ana hat öner (başlıklar ve her başlık altında 2–3 madde). Metin yazma.
> Adım 2 – Ben ana hattı düzeltip onaylayınca her bölümü ayrı yaz; her bölümden sonra dur ve onayımı bekle.
> Adım 3 – Tüm bölümler bitince tekrar eden, çelişen veya eksik kalan noktaları listele.
> Hedef kitle: **[KİTLE]**. Toplam uzunluk: en fazla **[UZUNLUK]**.
> Kaynak yazma; kaynak gereken yerlere **[KAYNAK]** koy.

▸ **İpucu:** Uzun sohbetlerde YZ ilk konuşulanları "unutabilir" (bağlam penceresi, stajyerin not defteri gibidir). Onaylanan ana hattı her yeni adımda kısaca yeniden yapıştırıyoruz.

▲ **Dikkat:** Adım adım çalışmak doğruluğu garanti etmez, yalnızca kontrolü kolaylaştırır. Klinik bilgileri güncel rehberle karşılaştırıyoruz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

1.6 Aynı içerik, farklı kitle

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Tek bir metni akademisyen, öğrenci, klinisyen veya hasta yakını için yeniden yazdırır.

> Aşağıdaki metni **[KİTLE, ör. lisans 2. sınıf beslenme öğrencisi / hasta yakını / klinik hemşire]** için yeniden yaz.
> – Bilgi içeriğini değiştirme; yeni bilgi ekleme. Bir bilgiyi çıkarırsan sonunda nedenini yaz.
> – Dil düzeyi: **[DÜZEY, ör. ortaokul mezunu bir okuyucunun anlayacağı kadar sade]**.
> – Teknik terimleri ilk geçtikleri yerde parantez içinde açıkla.
> – Uzunluk: **[UZUNLUK]**.
> Metin: '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** Kurgusal diyabet RKÇ özetiyle (ornekler/04) deneyin ve her sürümü okunabilirlik hesaplayıcısıyla (Excel) ölçüyoruz.

▲ **Dikkat:** Sadeleştirirken sayılar ve koşullar (“ateş 38 °C'nin üstündeyse”) kolayca kaybolur ya da değişir. Her sayıyı orijinalle karşılaştırıyoruz.

1.7 Geri bildirimle düzelttirme (yinelemeli istem)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? İlk çıktıyı ölçülebilir geri bildirimle ikinci ve üçüncü taslağa taşır.

> Önceki yanıtını aşağıdaki geri bildirimlere göre düzelt:
> 1. **[SORUN 1, ör. cümleler hâlâ uzun; hiçbir cümle 12 kelimeyi geçmesin]**
> 2. **[SORUN 2, ör. “hipoglisemi” terimini açıklamadan kullanmışsın]**
> 3. **[SORUN 3, ör. ayak bakımı bölümü eksik; günlük kontrol adımlarını ekle]**
> Değiştirmediğin bölümleri aynen koru. Yanıtın sonunda yaptığın değişiklikleri madde madde listele ve her birinin hangi geri bildirimi karşıladığını numarasıyla belirt.

▸ **İpucu:** “Daha iyi yap” gibi belirsiz geri bildirim yerine ölçülebilir geri bildirim veriyoruz: kelime sayısı, cümle uzunluğu, eksik başlık. Döngü: iste → oku → kontrol et → geri bildir (Şekil 1.12).

▲ **Dikkat:** Her düzeltme turunda YZ önceki doğru bilgileri de bozabilir. Son sürümü değişiklik listesine bakarak değil, baştan sona okuyarak onaylıyoruz.

1.8 Yanıt biçimini sabitleme (tablo kalıbı)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Çıktının her seferinde aynı tablo düzeninde gelmesini sağlar; Word'e veya Excel'e aktarmayı kolaylaştırır.

> Yanıtını yalnızca aşağıdaki tablo biçiminde ver; giriş ve kapanış cümlesi yazma.
> | **[SÜTUN 1]** | **[SÜTUN 2]** | **[SÜTUN 3]** | Emin misin? (evet / hayır / kısmen) |
> Kurallar:
> – Her satır tek bir **[BİRİM, ör. makale / ilaç / öğrenme hedefi]** olsun.
> – Bilgi yoksa hücreye “belirtilmemiş” yaz; tahmin etme.
> – Tablodan sonra en fazla 3 maddelik bir “Notlar” bölümü ekleyebilirsin.
> Kaynak metin: '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** Tablo Word'e yapıştırınca bozulursa “sekmeyle ayrılmış düz metin olarak ver” örneğin; bu biçim Excel'e doğrudan yapışır.

▲ **Dikkat:** “Emin misin?” sütunu yalnızca bir sinyaldir; YZ yanlış bir bilgiye de “evet” yazabilir. Doğrulamanın yerini tutmaz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

1.9 Uzun belgeyi parça parça işleme

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Bağlam penceresini aşan uzun metinleri (tez bölümü, rehber) bölerek güvenli biçimde işletir.

> Sana **[BELGE TÜRÜ, ör. tez taslağımın 40 sayfalık Tartışma bölümü]** parçalar hâlinde göndereceğim.
> – Her parçadan sonra yalnızca "Parça N alındı" yaz ve 3 maddelik kısa bir özet çıkar. Yorum yapma.
> – Ben "TÜM PARÇALAR BİTTİ" yazınca şu görevi yap: **[ASIL GÖREV, ör. bölümler arasındaki tekrarları ve çelişkileri tablo hâlinde listele]**.
> – Tabloda her bulgunun hangi parçadan geldiğini (Parça 1, Parça 2 ...) belirt.
> Parça 1: '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** Türkçe metin İngilizceye göre yaklaşık iki kat token harcar; not defteri daha çabuk dolar. Parçaları 2–3 sayfayla sınırlı tutuyoruz.

▲ **Dikkat:** Yayımlanmamış metinleri yüklemeden önce aracın veri politikasına ve kurum kurallarına bakıyoruz. Öğrencinin tezi, öğrencinin izni olmadan yüklenmez.

2. Literatür tarama, özetleme ve veri çıkarma

Literatürde YZ, kütüphanedeki hevesli öğrenci yardımcıya benzer: çok hızlı getirir, ama bazen yanlış rafa bakar, bazen de olmayan kitabı getirdiğini söyler. Bu bölümdeki istemler YZ'yi **arama stratejisi kurmak ve elinizdeki belgeyi okumak** için kullanır; aramayı veritabanında (PubMed, CINAHL, TR Dizin, Google Scholar) **kendiniz** yaparsınız. Özetleme ve veri çıkarmada belgeye dayalı araçlar (açık kitap sınavı) tercih edilir.

> ■ **Kaynakları YZ'ye yazdırmamanızı öneririz**
>
> Serbest bir sohbet botundan kaynak listesi istememenizi öneririz. Walters ve Wilder (2023) çalışmasında uydurma kaynak oranı GPT-3.5'te **%55**, GPT-4'te **%18** bulunmuştur; gerçek kaynakların da önemli bir kısmında hata vardır. Her kaynağı açıp okuyoruz (bkz. 7.5).

2.1 Araştırma fikrini PICO'ya dönüştürme

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Dağınık bir araştırma fikrini PICO bileşenlerine ayırır ve odaklı bir soru önerir.

> Rol: Sağlık bilimlerinde sistematik derleme deneyimi olan bir araştırma danışmanı olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki araştırma fikrimi PICO bileşenlerine ayır: P (hasta/popülasyon), I (girişim), C (karşılaştırma), O (sonuç).
> Amaç: Literatür taramasına başlamadan önce odaklı bir araştırma sorusu yazmak.
> Biçim: 4 satırlık tablo; ardından tek cümlelik PICO sorusu (Türkçe ve İngilizce). Her bileşen için daha dar ve daha geniş birer alternatif öner.
> Sınırlar: Fikrimde olmayan bir bileşeni uydurma; eksikse "belirtilmemiş, seçenekler: ..." yaz. Kaynak önerme.
> Fikrim: '''**[ARAŞTIRMA FİKRİNİZ, ör. Tip 2 diyabetli hastalarda hemşire liderliğinde mobil uygulama destekli eğitim HbA1c'yi düşürür mü?]**'''

▸ **İpucu:** Tersinden de pratik yapıyoruz: kurgusal RKÇ özetini (ornekler/04) yapıştırıp "Bu çalışmanın PICO'su nedir?" diye soruyoruz (Şekil 2.2).

▲ **Dikkat:** Nitel çalışmalar için PICO uygun olmayabilir. "Çalışma türüme uygun soru çerçevesini öner ve nedenini yaz" ekleyebilirsiniz.

Prof. Dr. AKADEMİ

2.2 Eş anlamlılar ve MeSH önerileri

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Her PICO bileşeni için Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri, eş anlamlıları ve olası MeSH başlıklarını listeler.

> Aşağıdaki PICO için bir arama terimi tablosu hazırla.
> Sütunlar: PICO bileşeni | Türkçe anahtar kelimeler | İngilizce anahtar kelimeler ve eş anlamlılar (yazım varyantları, kısaltmalar) | Olası MeSH başlığı | Emin misin?
> Kurallar:
> – Bir MeSH başlığından emin değilsen “MeSH Browser'da kontrol et” yaz; başlık uydurma.
> – Kesme işareti (ör. nurs*) kullanılabilecek terimleri işaretle.
> – Her bileşen için en az 4 terim öner; Türkçe yazım varyantlarını da ekle (ör. öz yönetim / öz-yönetim).
> PICO: '''**[PICO]**'''

▸ **İpucu:** Önerilen her MeSH başlığını NLM MeSH Browser'da aratın ve tanımını okuyoruz; Türkçe varyantlar TR Dizin araması için işe yarar.

▲ **Dikkat:** YZ, gerçek MeSH'e çok benzeyen ama var olmayan başlıklar üretebilir. Doğrulanmamış başlığı arama dizisine koymamanızı öneririz.

2.3 Boolean arama dizisi taslağı

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Terim tablosundan PubMed veya CINAHL için AND / OR / NOT içeren bir arama dizisi taslağı oluşturur.

> Rol: Deneyimli bir tıp kütüphanecisi olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki terim tablosundan **[VERİTABANI, ör. PubMed]** için bir arama dizisi taslağı yaz.
> Kurallar:
> – Aynı bileşenin terimlerini OR ile, farklı bileşenleri AND ile bağla; her bileşeni paranteze al.
> – MeSH için [Mesh], serbest metin için [tiab] alan etiketlerini kullan.
> – NOT operatörünü yalnızca gerekçesini yazarak kullan.
> – Diziyi tek blok hâlinde ver; altında her satırın ne işe yaradığını açıkla.
> – Yıl, dil ve çalışma türü filtrelerini dizinin içine değil, ayrı bir “önerilen filtreler” listesine yaz.
> Terim tablosu: '''**[TERİM TABLOSU]**'''

▸ **İpucu:** Diziyi veritabanında KENDİNİZ çalıştırıyoruz ve sonuç sayısını not ediyoruz. Çok fazla veya çok az sonuç çıkarsa 2.4'e geçiyoruz (Şekil 2.3).

▲ **Dikkat:** YZ'nin “bu dizi yaklaşık 250 sonuç verir” gibi sayıları tahmindir; veritabanına bağlı değilse sonuç sayısını bilemez.

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞLI

2.4 Arama dizisini daraltma veya genişletme

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Veritabanında aldığınız sonuç sayısına ve gözleminize göre diziyi ayarlamanıza yardım eder.

> **[VERİTABANI]** üzerinde aşağıdaki diziyi çalıştırdım ve **[SONUÇ SAYISI]** sonuç aldım. Hedefim yaklaşık **[HEDEF ARALIK, ör. 100–300]** kayıt.
> İlk 20 kaydın başlıklarında şu sorunu gördüm: **[GÖZLEMİNİZ, ör. çoğu tip 1 diyabetli çocuklarla ilgili]**.
> – Diziyi **[DARALTMAK / GENİŞLETMEK]** için 3 seçenek öner.
> – Her seçeneğin neyi değiştirdiğini ve hangi ilgili çalışmaları kaçırma riski taşıdığını yaz.
> – Seçenekleri en az riskliden en riskliye doğru sırala.
> Dizi: '''**[ARAMA DİZİSİ]**'''

▸ **İpucu:** Her denemeyi tarih, dizi ve sonuç sayısıyla bir tabloya kaydediyoruz; bu kayıt PRISMA akış şeması ve Yöntem bölümü için gereklidir.

▲ **Dikkat:** Her daraltma ilgili çalışma kaybı riski taşır. Sistematik derlemede dizinin son hâlini bir kütüphaneci veya deneyimli bir meslektaş gözden geçirsin.

2.5 Dahil etme ve dışlama kriterleri

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? PICO'ya dayalı, tarama sırasında tutarlı uygulanabilecek bir kriter listesi taslağı üretir.

> Rol: Sistematik derleme protokolü yazan bir araştırmacı olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki PICO ve amaca göre dahil etme ve dışlama kriterleri taslağı yaz.
> Biçim: İki sütunlu tablo (Dahil etme | Dışlama). Satırlar: popülasyon, girişim, karşılaştırma, sonuç, çalışma tasarımı, yayın dili, yayın yılı, yayın türü.
> Ek olarak: İki bağımsız değerlendiricinin farklı karar verebileceği 3 “gri bölge” örneği yaz ve her biri için bir karar kuralı öner.
> Sınırlar: Yıl ve dil sınırlarını ben belirleyeceğim; bunları **[BELİRLENECEK]** olarak bırak.
> PICO ve amaç: '''**[PICO VE AMAÇ]**'''

▸ **İpucu:** Kriterleri ilk 20–30 özette pilot olarak deneyin; iki değerlendiricinin ayrıştığı yerleri yeni bir karar kuralına dönüştürüyoruz.

▲ **Dikkat:** Dahil/dışla kararını YZ'ye bırakmamanızı öneririz. YZ yalnızca kriter taslağı ve gerekçe önerir; karar ve sorumluluk araştırmacınındır.

2.6 Belgeye dayalı makale özeti

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** belgeye dayalı araç (NotebookLM, dosya yükleme)

Ne işe yarar? Yüklediğiniz makaleyi yalnızca o belgeye dayanarak, sayfa göstererek özetletir.

> Yalnızca yüklediğim belgeye dayan; genel bilgini ve başka çalışmaları kullanma.
> Görev: Bu makaleyi şu başlıklarla özetle: Amaç | Tasarım | Örneklem ve ortam | Girişim veya maruziyet | Ana sonuçlar (sayılarla) | Yazarların belirttiği sınırlılıklar | Klinik çıkarım.
> Kurallar:
> – Her maddenin sonuna sayfa veya tablo numarasını yaz (ör. s. 5, Tablo 2).
> – Belgede olmayan bilgi için “belgede belirtilmemiş” yaz.
> – Sayıları (n, ortalama, %95 GA, p) metindeki gibi aynen aktar; yuvarlama.
> – Toplam en fazla **[KELİME SINIRI]** kelime.
> Okuyucu: **[KİTLE, ör. konuya yabancı bir yüksek lisans öğrencisi]**.

▸ **İpucu:** Kapalı kitap yerine açık kitap sınavı (Şekil 2.6): atıflara tıklayıp sayfayı açıyoruz. Kurgusal RKÇ özetinde HbA1c farkının −0,8 (%95 GA −1,2 ile −0,4) olarak doğru aktarılıp aktarılmadığına bakıyoruz.

▲ **Dikkat:** Belgeye dayalı araç da yanlış sayfa gösterebilir veya iki bulguyu karıştırabilir. Telifli tam metinleri yüklemeden önce aracın ve yayıncının koşullarını kontrol ediyoruz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

2.7 Çok makaleli karşılaştırma tablosu

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** belgeye dayalı araç (NotebookLM, dosya yükleme)

Ne işe yarar? Birden fazla makaleyi aynı ölçütlerle yan yana koyar; derleme ve Tartışma yazımına hazırlık sağlar.

> Yüklediğim **[SAYI]** makaleyi yalnızca bu belgelere dayanarak karşılaştır.
> Tablo sütunları: Yazar ve yıl (belgedeki gibi) | Ülke ve ortam | Tasarım | Örneklem (n) | Girişim ve süre | Kontrol grubu | Ana sonuç ölçütü | Temel bulgu (sayılarla) | Kaynak yer (sayfa/tablo).
> Tablodan sonra:
> 1. Ortak bulguları 3 maddede yaz.
> 2. Çelişen bulguları ve olası nedenlerini (örneklem, süre, ölçüm farkı) yaz.
> 3. Bu makalelerden çıkan bilgi boşluklarını 3 maddede öner; her birinin hangi makalelerden çıkarıldığını belirt.
> Belgede olmayan bilgi için "belirtilmemiş" yaz.

▸ **İpucu:** Makale sayısı arttıkça hata riski artar. Tek seferde 4–5 makaleden fazlasını vermiyoruz, tabloları sonra birleştiriyoruz.

▲ **Dikkat:** "Bilgi boşluğu" önerileri yalnızca yüklediğiniz makalelere dayanır; gerçek bir boşluğu göstermek için kapsamlı tarama gerekir.

2.8 Veri çıkarma tablosu (sayfa/tablo sütunlu)

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** belgeye dayalı araç (NotebookLM, dosya yükleme)

Ne işe yarar? Sistematik derleme için standart veri çıkarma formunu doldurtur ve her verinin yerini gösterir.

> Rol: Sistematik derlemede ikinci veri çıkarıcı olarak çalış.
> Görev: Yüklediğim makaleden aşağıdaki alanları çıkar.
> Biçim: 3 sütunlu tablo: Alan | Çıkarılan bilgi (metindeki ifadeyle) | Sayfa/tablo.
> Alanlar: **[ALAN LİSTESİ, ör. tasarım; randomizasyon yöntemi; körleme; randomize edilen n; analize alınan n; kayıplar ve nedenleri; girişimin içeriği ve süresi; sonuç ölçütü ve ölçüm zamanı; grup ortalamaları ve SS; grup farkı ve %95 GA; p değeri; yan etkiler; finansman]**.
> Kurallar: Hesaplama yapma, yalnızca metinde yazanı aktar. Bulunamayan alana "bulunamadı" yaz. Yorum ekleme.

▸ **İpucu:** Şekil 2.9'daki şablonu kullanıyoruz. Birinci veri çıkarıcı sizsiniz, YZ ikinci çıkarıcıdır; uyuşmayan hücreleri makaleden kontrol ediyoruz.

▲ **Dikkat:** Sayfa/tablo sütunu olmayan bir veri çıkarma tablosu doğrulanamaz. Kurgusal özette 120 randomize edilen ve 108 tamamlayan iki ayrı n vardır; YZ bunları sık karıştırır.

2.9 Sınırlılık ve yanlılık avı (eleştirel okuma)

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** belgeye dayalı araç (NotebookLM, dosya yükleme)

Ne işe yarar? Bir makalenin olası sınırlılıklarını ve yanlılık kaynaklarını metindeki dayanaklarıyla listeler.

> Rol: Deneyimli ve adil bir hakem olarak çalış.
> Görev: Yüklediğim **[ÇALIŞMA TÜRÜ, ör. randomize kontrollü çalışma]** makalesini eleştirel olarak oku.
> Biçim:
> 1. Yazarların kendi belirttiği sınırlılıklar (sayfa numarasıyla).
> 2. Yazarların belirtmediği ama metinden çıkarılabilecek olası sınırlılıklar; her biri için metindeki dayanağı alıntıla ve sayfasını yaz.
> 3. Seçim, performans, tespit, kayıp ve raporlama yanlılığı için "metinde yanıtı var / yok" tablosu.
> Sınırlar: Dayanağı metinde olmayan eleştiri yazma. Kesin hüküm verme; "olası" ve "metinde belirtilmemiş" ifadelerini kullan.

▸ **İpucu:** Kurgusal özette katılımcıların %38'i 12. haftadan sonra uygulamayı haftada birden az kullanmıştır. YZ bunu sınırlılık olarak yakaladı mı?

▲ **Dikkat:** Resmî yanlılık riski değerlendirmesi eğitimli iki değerlendirici ve standart bir araç gerektirir; bu istem yalnızca ön okuma içindir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

2.10 Aynı çalışmayı üç kitleye özetleme

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Aynı çalışmayı akademisyen, lisans öğrencisi ve hasta için ayrı dil düzeylerinde özetler.

> Aşağıdaki çalışma özetini üç farklı okuyucu için ayrı ayrı yeniden yaz:
> A) Akademisyen: 150 kelime; teknik terimler serbest; sayılar ve güven aralıkları korunur.
> B) Lisans **[BÖLÜM]** öğrencisi: 150 kelime; teknik terimler ilk geçişte açıklanır; istatistik sade anlatılır.
> C) Hasta veya hasta yakını: 100 kelime; cümleler en fazla 12 kelime; istatistik terimi yok; "Bu sizin için ne anlama gelir?" cümlesiyle biter; tedavi önerisi verme.
> Üç sürümde bilgi içeriği aynı kalsın; yeni bilgi ekleme.
> Özet: '''**[ÇALIŞMA ÖZETİ]**'''

▸ **İpucu:** Her sürümü okunabilirlik hesaplayıcısıyla ölçüyoruz. Eğitimdeki örnekte Ateşman puanları akademisyen 13,0, öğrenci 69,0 ve hasta 82,5 çıkmıştı (Şekil 2.7).

▲ **Dikkat:** Hasta sürümünde aşırı genelleme kolayca oluşur ("uygulama şekeri düşürüyor"). Tek bir çalışmanın sonucu hastaya kesin bilgi gibi sunulmaz.

3. Akademik yazım

Akademik yazımda YZ bir dil editörüdür, hayalet yazar değildir. **Sandviç modeli** uygulanır: önce siz düşünür ve içeriği verirsiniz, YZ taslak veya düzeltme önerir, en sonda siz kontrol eder ve imzalarsınız. YZ yazar olamaz; kullanım şeffaf biçimde beyan edilir; sorumluluk araştırmacıdadır (ICMJE; YÖK, 2024). Şekil 3.2'deki kırmızı bölgeye girmemenizi öneririz.

3.1 Başlık önerileri

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Çalışmanız için farklı türlerde, abartısız başlık seçenekleri üretir.

> Rol: **[ALAN]** alanında hakemli dergilerde editörlük deneyimi olan bir akademisyen olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki özete dayanarak **[SAYI, ör. 5]** başlık önerisi yaz: en az biri betimleyici, biri soru biçiminde, biri ana bulguyu vurgulayan, biri çalışma tasarımını içeren ("...: randomize kontrollü bir çalışma") olsun.
> Kurallar:
> – Her başlık en fazla **[KELİME SINIRI]** kelime.
> – Özette olmayan bir bulguyu başlığa koyma; sonucu abartma ("devrim", "kesin çözüm" gibi ifadeler yok).
> – Her başlığın Türkçe ve İngilizce sürümünü ver.
> Hedef dergi ve başlık kuralları: **[DERGİ ADI VE KURALLARI]**
> Özet: '''**[ÖZET]**'''

▸ **İpucu:** Derginin yazar rehberindeki başlık kurallarını (karakter sınırı, kısaltma yasağı) isteme ekliyoruz.

▲ **Dikkat:** Bulguyu vurgulayan başlıklar nedensellik iması taşıyabilir. Kesitsel çalışmada "etkisi" yerine "ilişkisi" gibi ifadeler kullanıyoruz.

Prof. Dr. Ali KIDAĞLI

3.2 Yapılandırılmış özet

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Notlarınızdan dergi biçimine uygun, sayıları korunmuş bir yapılandırılmış özet taslağı hazırlar.

> Görev: Aşağıdaki çalışma bilgilerinden **[KELİME SINIRI, ör. 250]** kelimelik yapılandırılmış özet taslağı yaz.
> Başlıklar: Amaç | Yöntem | Bulgular | Sonuç (dergi farklı başlık istiyorsa: **[DERGİNİN BAŞLIKLARI]**).
> Kurallar:
> – Yalnızca verdiğim bilgileri kullan; yeni sayı, yüzde veya p değeri üretme.
> – Birincil sonucu etki büyüklüğü ve %95 GA ile ver; anlamlı olmayan birincil veya ikincil sonuçları da çıkarma.
> – Sonuç cümlesi bulguların ötesine geçmesin.
> – Sona 4–6 anahtar kelime öner; MeSH ile uyumundan emin değilsen **[KONTROL ET]** yaz.
> Çalışma bilgileri: '''**[AMAÇ, YÖNTEM, BULGU VE SONUÇ NOTLARINIZ]**'''

▸ **İpucu:** Kurgusal RKÇ (ornekler/04) ile deneyin: ilaç uyumunun değişmediği bilgisi (p=0,18) özette kaldı mı, yoksa yalnızca olumlu bulgular mı seçildi?

▲ **Dikkat:** Özetteki her sayıyı orijinal tablo ile tek tek karşılaştırıyoruz. YZ kelime sayısını sık yanlış sayar; Word'ün sayacını kullanıyoruz.

3.3 Giriş bölümü planı ([KAYNAK] yer tutuculu)

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Giriş bölümünün mantık akışını kurar; kaynak uydurmadan, kaynak gereken yerleri işaretler.

> Rol: **[ALAN]** alanında makale yazımında deneyimli bir öğretim üyesi olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki çalışma için önce Giriş bölümünün planını, sonra **[PARAGRAF SAYISI]** paragraflık taslağını yaz.
> Akış: sorunun önemi → mevcut bilgi → bilgi boşluğu → çalışmanın amacı.
> Kurallar:
> – HİÇBİR kaynak, yazar adı, yıl, dergi veya istatistik yazma.
> – Kaynağa dayanması gereken her iddianın sonuna **[KAYNAK]** koy ve ne tür bir kaynak gerektiğini yaz, ör. **[KAYNAK: Türkiye'de tip 2 diyabet sıklığı]**.
> – Sayı gereken yerleri **[SAYI GEREKLİ]** olarak bırak.
> – Planı ve taslağı ayrı başlıklarla ver.
> Çalışma özeti: '''**[ÇALIŞMA ÖZETİ VEYA PICO]**'''

▸ **İpucu:** Her [KAYNAK] için gerçek kaynağı veritabanında kendimiz buluyoruz. Bulduğunuz kaynak iddiayı desteklemiyorsa kaynağı değil cümleyi değiştiriyoruz.

▲ **Dikkat:** "Kaynakları da ekle" demiyoruz: serbest modellerde uydurma kaynak oranı yüksektir (Walters ve Wilder, 2023). Kaynak listesi yazdırıp kontrolsüz kullanmak Şekil 3.2'de kırmızı bölgededir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

3.4 Yöntem bölümünü raporlama rehberine göre kontrol

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Yöntem bölümünüzü ilgili raporlama rehberinin konularına göre eksiklik açısından tarar.

> Rol: Raporlama rehberlerini iyi bilen bir dergi editörü olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki Yöntem bölümü taslağımı **[REHBER: randomize çalışma için CONSORT / gözlemsel çalışma için STROBE / büyük dil modeli kullanan çalışma için TRIPOD-LLM]** açısından kontrol et.
> Biçim: Tablo: Rehber maddesinin konusu | Metnimde var mı? (var / kısmen / yok) | Metindeki yeri (cümleyi alıntıla) | Eksikse ne eklenmeli.
> Kurallar:
> – Madde numarasından emin değilsen numara yazma, yalnızca konuyu yaz ve **[KONTROL ET]** ekle.
> – Metnimi yeniden yazma; yalnızca eksikleri göster.
> Yöntem bölümüm: '''**[YÖNTEM METNİ]**'''

▸ **İpucu:** Rehberin resmî kontrol listesini (EQUATOR Network sitesinden) indiriyoruz; mümkünse listeyi de yükleyip "yalnızca bu listeye göre kontrol et" örneğin.

▲ **Dikkat:** YZ rehber maddelerini eski sürümle karıştırabilir veya uydurabilir. TRIPOD-LLM (Gallifant ve ark., 2025) yeni bir rehberdir; modelin eğitim verisinde hiç olmayabilir. Dergiye gönderilecek listeyi siz doldurursunuz.

3.5 Bulgular ile tablolar arasında tutarlılık kontrolü

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Metindeki sayıların tablolarla uyuşup uyuşmadığını ve yüzde-toplam hatalarını raporlar.

> Görev: Aşağıdaki Bulgular metnini ve tabloları karşılaştır. Hiçbir şeyi düzeltme, yalnızca raporla.
> Kontrol et:
> 1. Metinde geçen her sayı tabloda aynı mı? (n, ortalama, SS, %, p, GA)
> 2. Yüzdeler verilen n'lerle uyumlu mu? Satır ve sütun toplamları doğru mu? Hesabını göster.
> 3. Metinde olup tabloda olmayan ya da tabloda olup metinde hiç anılmayan bulgu var mı?
> 4. Ondalık ayırıcı, birim ve kısaltma tutarlı mı?
> Biçim: Tablo: Konum | Metindeki ifade | Tablodaki değer | Sorun türü | Öneri.
> Metin: '''**[BULGULAR METNİ]**'''
> Tablolar: '''**[TABLOLAR, düz metin olarak]**'''

▸ **İpucu:** Tabloları Word'den düz metin olarak yapıştırıyoruz; resim olarak verilen tablolarda okuma hatası artar.

▲ **Dikkat:** YZ aritmetikte hata yapabilir. İşaretlediği her tutarsızlığı hesap makinesiyle doğruluyoruz; "sorun yok" yanıtı kontrolün bittiği anlamına gelmez.

PROF. DR. EMİN AKDAĞLI

3.6 Tartışma için karşı argüman (şeytanın avukatı)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Bulgularınıza bir hakemin getirebileceği itirazları önceden görmenizi sağlar.

> Rol: Çalışmama şüpheyle yaklaşan, titiz ama adil bir hakem ol.
> Görev: Aşağıdaki ana bulgularım ve yorumlarım için en güçlü 5 karşı argümanı yaz.
> Her argüman için:
> (a) itirazın kendisi;
> (b) dayandığı alternatif açıklama (karıştırıcı değişken, seçim yanlılığı, ölçüm sorunu, tesadüf vb.);
> (c) Tartışma bölümünde bu itiraza nasıl yanıt verebileceğim;
> (d) ek analiz veya veri gerekiyorsa ne olduğu.
> Sınırlar: Literatürden kaynak veya çalışma adı uydurma; dış kanıt gereken yerde **[KAYNAK GEREKLİ]** yaz.
> Bulgular ve yorumlarım: '''**[ANA BULGULAR VE YORUMLAR]**'''

▸ **İpucu:** Kurgusal RKÇ'de öz yeterlilik artmış ama ilaç uyumu değişmemiştir. YZ bu ayrışma için hangi açıklamaları öneriyor?

▲ **Dikkat:** Karşı argümanlar ikna edici görünebilir ama verinizle ilgisiz olabilir. Yalnızca tasarımınıza gerçekten uyanları Tartışma'ya taşıyoruz.

3.7 Sınırlılıklar paragrafı

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Çalışmanızın tasarımından kaynaklanan sınırlılıkları dürüst ve dengeli bir paragrafa dönüştürür.

> Görev: Aşağıdaki çalışma özelliklerinden bir "Sınırlılıklar" paragrafı taslağı yaz.
> Her sınırlılık için şu sırayı izle: ne olduğu → sonuçları hangi yönde etkileyebileceği → azaltmak için ne yapıldığı (yapıldıysa) → gelecek çalışmalar için öneri.
> Kurallar:
> – Yalnızca listelediğim özellikleri kullan; yapılmamış bir yöntemi yapılmış gibi yazma.
> – Savunmacı veya aşırı özür dileyen bir dil kullanma.
> – Uzunluk: **[KELİME SINIRI]**.
> Çalışma özellikleri: '''**[TASARIM, ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, ÖLÇÜM ARAÇLARI, KAYIPLAR, İZLEM SÜRESİ, BİLDİĞİNİZ SINIRLILIKLAR]**'''

▸ **İpucu:** Önce 2.9'daki eleştirel okuma istemini kendi taslağınıza uyguluyoruz; çıkan listeyi bu isteme girdi yapıyoruz.

▲ **Dikkat:** YZ "genellenebilirlik sınırlıdır" gibi kalıp cümleler üretir. Okura bilgi vermeyen genel cümleleri çıkarıyoruz, çalışmanıza özgü olanları bırakıyoruz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

3.8 Dil düzeltme (anlamı koruyarak, değişiklikleri listeleyerek)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Kendi yazdığınız paragrafı dil bilgisi ve akıcılık açısından düzeltir, her değişikliği gerekçesiyle listeler.

> Rol: Sağlık bilimleri makalelerinde deneyimli bir Türkçe dil editörü olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki paragrafımı dil bilgisi, yazım, noktalama ve akıcılık açısından düzelt.
> Kurallar:
> – Anlamı, iddianın gücünü ve terimleri DEĞİŞTİRME (“anlamlı ilişki” → “güçlü etki” gibi değişiklikler yasak).
> – Sayıları, birimleri ve atıfları olduğu gibi bırak; yeni bilgi veya cümle ekleme.
> Biçim:
> 1. Düzeltilmiş metin.
> 2. Değişiklik tablosu: Orijinal ifade | Yeni ifade | Gerekçe (dil bilgisi / yazım / akıcılık / üslup).
> 3. Anlamı değişmiş olabilecek yerleri ayrıca **[KONTROL ET]** ile listele.
> Metnim: '''**[PARAGRAFINIZ]**'''

▸ **İpucu:** Düzeltilmiş metni Word'de Gözden Geçir → Karşılaştır ile orijinaliyle karşılaştırıyoruz ve değişiklikleri tek tek kabul ediyoruz.

▲ **Dikkat:** Akıcılık için yapılan küçük değişiklikler anlamı kaydırabilir (“ilişkili bulundu” → “etkiledi”). Bu kullanım da beyan gerektirebilir; derginin politikasına bakıyoruz.

3.9 İngilizce çeviri ve terim kontrolü

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Türkçe metninizi akademik İngilizceye çevirir ve terim seçimlerini bir tabloyla gösterir.

> Rol: Sağlık bilimlerinde uzman bir akademik çevirmen olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki Türkçe metni **[HEDEF, ör. uluslararası bir hemşirelik dergisi]** için akademik İngilizceye çevir.
> Yazım tercihi: **[AMERİKAN / İNGİLİZ İNGİLİZCESİ]**.
> Kurallar:
> – Anlamı ve iddianın gücünü koru; serbest yorum yapma.
> – Ölçek, ölçüm aracı ve girişim adlarını yerleşik İngilizce adlarıyla yaz; emin değilsen **[KONTROL ET]** ekle.
> – Ondalık ayırıcıyı İngilizce kullanıma göre (nokta) değiştir.
> Biçim: 1) Çeviri. 2) Terim tablosu: Türkçe terim | Kullanılan karşılık | Alternatifler | Emin misin?
> Terim tercihlerim: **[VARSA SÖZLÜĞÜNÜZ, ör. öz yönetim = self-management]**
> Metin: '''**[TÜRKÇE METİN]**'''

▸ **İpucu:** Çeviriyi ayrı bir sohbette yeniden Türkçeye çevirtin (geri çeviri); anlam kaymaları hızla görünür.

▲ **Dikkat:** Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış ölçeklerin adlarında ve alt boyutlarında hata sık görülür; ölçeğin orijinal makalesine bakıyoruz. Ondalık dönüşümünü tek tek kontrol ediyoruz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

3.10 Hakem yorumlarına yanıt mektubu

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Hakem yorumlarına kibar, yapılandırılmış ve madde madde bir yanıt mektubu taslağı hazırlar.

> Rol: Çok sayıda revizyon sürecini yönetmiş deneyimli bir sorumlu yazar olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki hakem yorumlarına yanıt mektubu taslağı yaz.
> Biçim: Her yorum için: “Hakem yorumu” (aynen) → “Yanıtımız” → “Yapılan değişiklik ve yeri (sayfa/satır)”.
> Kurallar:
> – Ton: teşekkür eden, saygılı, savunmacı olmayan; katılmadığımız noktada gerekçeli ve kibar.
> – Notlarımda olmayan bir değişikliği yapılmış gibi yazma; eksik yerlere **[YAPILACAK DEĞİŞİKLİK]** yaz.
> – Yeni analiz veya kaynak uydurma.
> Hakem yorumları: '''**[HAKEM YORUMLARI]**'''
> Her yorum için notlarım: '''**[YAPTIĞINIZ VEYA YAPACAĞINIZ DEĞİŞİKLİKLER]**'''

▸ **İpucu:** Eğitimde bu istemi KURGUSAL bir hakem metniyle deneyin. Gerçek hakem raporları gizli olabilir; kullanmadan önce dergi politikasına bakıyoruz, gerekirse yorumları kendi cümlelerinizle özetliyoruz.

▲ **Dikkat:** Siz hakemseniz durum tersine döner ve KIRMIZI olur: değerlendirdiğiniz makaleyi veya hakem raporunuzu gizliliği güvence altında olmayan bir YZ aracına yüklemiyoruz (ICMJE).

3.11 YZ kullanım beyanı yazdırma

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? YZ'yi hangi araçla, hangi aşamada ve ne ölçüde kullandığınızı şeffaf biçimde anlatan beyan taslağı hazırlar.

> Görev: Aşağıdaki bilgilere dayanarak makalem için Türkçe ve İngilizce bir “Yapay zekâ kullanım beyanı” taslağı yaz.
> Beyan şunları içersin: kullanılan araç ve sürümü/tarihi; hangi aşamada ve hangi amaçla kullanıldığı; ne ölçüde kullanıldığı; çıktıların yazarlarca nasıl kontrol edildiği; sorumluluğun yazarlara ait olduğu.
> Kurallar: Yalnızca verdiğim bilgileri kullan; kullanımı olduğundan az veya çok gösterme. YZ'yi yazar ya da kaynak olarak gösterme. Her dilde en fazla 80 kelime.
> Bilgiler:
> – Araç: **[ARAÇ ADI, SÜRÜMÜ VE KULLANIM TARİHİ]**
> – Aşama ve amaç: **[AŞAMA VE AMAÇ, ör. İngilizce dil düzeltme; arama terimi önerisi]**
> – Kontrol yöntemi: **[KONTROL, ör. tüm öneriler yazarlarca tek tek incelendi]**
> – Hedef dergi ve beyanın yeri: **[DERGİ ADI; YÖNTEM / TEŞEKKÜR / AYRI BÖLÜM]**

▸ **İpucu:** Şekil 3.7'deki örneklerle karşılaştırıyoruz. ICMJE, kullanımın hem kapak mektubunda hem makalede beyanını; YÖK rehberi hangi YZ işlevinin hangi aşamada ve ne ölçüde kullanıldığının açıklanmasını ister.

▲ **Dikkat:** Beyanın yerini ve biçimini derginin yazar rehberi belirler, YZ'nin önerisi değil. Şüphede kalırsanız beyan ediyoruz.

Prof. Dr. Mert AKDAĞLI

4. Eğitim ve öğretim

Ders hazırlığı, ölçme-değerlendirme ve geri bildirim, YZ'nin öğretim üyesine en çok zaman kazandırdığı alanlardır. Bu bölümdeki istemler hemşirelik, ebelik ve beslenme bölümleri için uyarlanabilir. Klinik içerik her zaman güncel rehber ve ders kitabıyla karşılaştırılır.

■ Öğrenci verisi ve dürüstlük

- Öğrenci ödevi, notu ve adı da **kişisel veridir**. Ödev metnini YZ'ye vermeden önce kimlik bilgilerini çıkarıyoruz ve kurum politikasına bakıyoruz.
- YZ dedektörlerinin sonucu **tek başına kanıt değildir**; insan yazısını sık sık "YZ yazdı" diye işaretleyebilirler. Değerlendirmeyi süreç kanıtına dayandırıyoruz (bkz. 4.7).
- Soru bankanızı ve sınav sorularınızı genel araçlara yüklememenizi öneririz; sınav güvenliği bozulabilir.

4.1 Ders planı

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Ölçülebilir hedefleri, zaman çizelgesi ve çıkış kartı olan bir ders planı taslağı hazırlar.

Rol: **[BÖLÜM]** alanında deneyimli, aktif öğrenme yöntemlerini kullanan bir öğretim üyesi olarak çalış.
Görev: "**[DERS KONUSU]**" konusunda **[SÜRE, ör. 2 × 50 dakikalık]** bir ders planı hazırla.
Kitle: **[SINIF DÜZEYİ VE ÖN BİLGİ, ör. 2. sınıf ebelik öğrencileri, fizyoloji dersini almışlar]**.
Biçim:
1. Ölçülebilir 3–5 öğrenme hedefi (Bloom düzeyi parantez içinde).
2. Zaman çizelgesi tablosu: Dakika | Etkinlik | Öğretim yöntemi | Öğretim üyesinin rolü | Öğrencinin rolü | Materyal.
3. Her hedef için bir ölçme yöntemi.
4. Ders sonunda 3 soruluk çıkış kartı.
Sınırlar: Klinik içerik **[REHBER VEYA DERS KİTABI]** ile uyumlu olsun; emin olmadığın klinik bilgiyi **[KONTROL ET]** ile işaretle.

▸ **İpucu:** Programınızın ilgili yeterliklerini veya program çıktılarını isteme ekliyoruz; plan doğrudan bunlarla eşleşir.

▲ **Dikkat:** Plandaki süreler genellikle iyimserdir; ilk uygulamadan sonra gerçek sürelere göre güncelliyoruz.

Prof. Dr. Fatih AKDAĞLI

4.2 Vaka senaryosu (hemşirelik, ebelik, beslenme)

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Öğrenme hedefine bağlı, aşamalı ilerleyen ve tamamen kurgusal bir vaka senaryosu yazar.

> Rol: **[BÖLÜM]** eğitiminde vaka temelli öğrenme kullanan bir öğretim üyesi olarak çalış.
> Görev: Tamamen kurgusal bir vaka senaryosu yaz.
> Konu ve ortam: **[KONU VE ORTAM, ör. hemşirelik: ameliyat sonrası 1. gün, cerrahi servis / ebelik: 34. gebelik haftası, preeklampsi şüphesi / beslenme: hemodiyaliz hastasıyla ilk beslenme görüşmesi]**
> Öğrenme hedefleri: **[2–3 HEDEF]**. Kitle: **[SINIF DÜZEYİ]**.
> Biçim:
> 1. Vaka öyküsü (en fazla 200 kelime; yaş, öykü, bulgular, yaşam bulguları, laboratuvar).
> 2. İki aşamalı ilerleme; her aşamada yeni bilgi.
> 3. Her aşamada 3 tartışma sorusu.
> 4. Öğretim üyesi için beklenen yanıtlar ve olası öğrenci yanılgıları.
> Sınırlar: Gerçek kişi, kurum veya yer adı kullanma. Laboratuvar değerleri klinik olarak tutarlı olsun; emin olmadığın değeri ve her ilaç dozunu **[KONTROL ET]** ile işaretle.

▸ **İpucu:** Aynı vakayı üç bölüm için de yazdırıp disiplinlerarası bir derste kullanabilirsiniz: aynı preeklampsi vakasında ebelik, hemşirelik ve beslenme soruları.

▲ **Dikkat:** Gerçek bir hastayı "biraz değiştirerek" anlatmak kimlik belirleyici olabilir; vakayı baştan kurguluyoruz. Laboratuvar değerlerini ve dozları uzman gözüyle kontrol ediyoruz.

4.3 OSCE istasyonu

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Bir klinik beceri için yönerge, standart hasta notu ve kontrol listesi içeren OSCE istasyonu taslağı hazırlar.

> Rol: OSCE sınavı tasarlamış bir klinik beceri eğitmeni olarak çalış.
> Görev: "**[BECERİ, ör. insülin kalemiyle subkutan enjeksiyon eğitimi verme / Leopold manevraları / 24 saatlik besin tüketim kaydı alma]**" için **[SÜRE, ör. 8 dakikalık]** bir OSCE istasyonu hazırla.
> Biçim:
> 1. Öğrenciye verilecek yönerge (en fazla 80 kelime).
> 2. Standart hasta için senaryo ve rol notları (söyleyeceği cümleler, sorulara vereceği yanıtlar).
> 3. Kontrol listesi: Adım | Yapıldı / Kısmen / Yapılmadı | Puan. Yapılmazsa kalınan kritik adımları işaretle.
> 4. Genel değerlendirme ölçeği (iletişim, hasta güvenliği, profesyonellik).
> 5. Malzeme listesi.
> Sınırlar: Adımlar **[KURUMUNUZUN BECERİ REHBERİ]** ile uyumlu olsun; kurumdan kuruma değişebilecek adımları **[KONTROL ET]** ile işaretle.

▸ **İpucu:** Kendi beceri laboratuvarı kontrol listenizi yapıştırıp "bunu OSCE biçimine dönüştür" demek, sıfırdan yazdırmaktan daha güvenilirdir.

▲ **Dikkat:** YZ'nin listesi kurum rehberinizin yerine geçmez. Puanlamayı sınavdan önce iki eğitmenle pilot olarak deneyin.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

4.4 Çoktan seçmeli soru ve çeldirici analizi

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Vaka köklü çoktan seçmeli sorular yazar ve her çeldiricinin hangi yanılgıyı ölçtüğünü açıklar.

> Rol: Ölçme-değerlendirme konusunda deneyimli bir **[BÖLÜM]** öğretim üyesi olarak çalış.
> Görev: "**[KONU]**" ile ilgili **[SAYI]** çoktan seçmeli soru yaz. Kitle: **[SINIF DÜZEYİ]**.
> Kurallar:
> – Her soru tek bir öğrenme hedefini ölçsün; hedefi ve Bloom düzeyini yaz (en az yarısı uygulama veya analiz düzeyinde).
> – Klinik vaka kökü kullan; kökte olumsuz ifade kullanma, kullanırsan büyük harfle yaz (DEĞİLDİR).
> – 5 seçenek, tek doğru yanıt; "hepsi / hiçbiri" seçeneği yok; seçenekler benzer uzunlukta.
> – Çeldirici analizi: Her yanlış seçeneğin hangi yaygın öğrenci yanılgısını temsil ettiğini bir cümleyle yaz.
> – Doğru yanıtın gerekçesini yaz; kaynak adı uydurma, gerekirse **[KAYNAK]** koy.

▸ **İpucu:** Sınavdan sonra madde analizi sonuçlarınızı (güçlük ve ayırt edicilik, öğrenci adı olmadan) verip zayıf çeldiricileri yeniden yazdırabilirsiniz.

▲ **Dikkat:** YZ'nin "tek doğru" dediği soruda iki doğru seçenek olabilir. Her soruyu bir meslektaşınız yanıtlamadan sınava koymamanızı öneririz.

4.5 Rubrik (dereceli puanlama anahtarı)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Bir ödev için gözlenebilir ölçütlere dayalı analitik rubrik taslağı hazırlar.

> Rol: **[BÖLÜM]** alanında ölçme-değerlendirme deneyimi olan bir öğretim üyesi olarak çalış.
> Görev: "**[ÖDEV TÜRÜ, ör. hemşirelik bakım planı / doğum sonu ev ziyareti raporu / bireysel beslenme planı]**" için analitik bir rubrik hazırla.
> Öğrenme hedefleri: **[HEDEFLER]**
> Biçim: Tablo: Ölçüt | Ağırlık (%) | Mükemmel (4) | İyi (3) | Geliştirilmeli (2) | Yetersiz (1).
> Kurallar:
> – 4–6 ölçüt; her düzey gözlenebilir davranışla tanımlansın ("iyi analiz eder" yerine "en az iki veri kaynağını karşılaştırır").
> – Ağırlıkların toplamı %100 olsun.
> – Ödevde YZ kullanımına izin veriliyorsa "YZ kullanımının şeffaf raporlanması" ölçütünü ekle.

▸ **İpucu:** Rubriği ödevle birlikte öğrencilere veriyoruz. Aynı rubrikle 2–3 örnek ödevi iki öğretim üyesi puanlayıp uyumu kontrol etsin.

▲ **Dikkat:** Ağırlık toplamını ve düzeyler arası tutarlılığı kendimiz kontrol ediyoruz; YZ bazen düzey atlar veya aynı tanımı tekrarlar.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

4.6 Öğrenciye yapıcı geri bildirim

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Anonim bir öğrenci ödevine rubriğe dayalı, somut ve yapıcı geri bildirim taslağı hazırlar.

> Rol: Destekleyici ama net geri bildirim veren bir öğretim üyesi olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki anonimleştirilmiş ödeve, verilen rubriğe göre geri bildirim taslağı yaz.
> Biçim:
> 1. Güçlü yönler: 2–3 madde, ödevden somut örnekle.
> 2. Geliştirilecek yönler: en fazla 3 madde; her biri için "nasıl geliştirebilirsin" önerisi.
> 3. Rubrik ölçütlerine göre önerilen düzey ve gerekçesi.
> 4. Öğrenciye "sen" diliyle hitap eden 3 cümlelik kapanış.
> Kurallar: Not kararını ben vereceğim; önerdiğin düzeyler yalnızca taslaktır. Ödevde olmayan bir şeyi eleştirme veya övme.
> Rubrik: '''**[RUBRİK]**'''
> Ödev (ad, numara ve kimlik bilgisi çıkarılmış): '''**[ANONİM ÖDEV METNİ]**'''

▸ **İpucu:** Aynı rubrikle birkaç ödeve geri bildirim alıp tutarlılığı karşılaştırıyoruz; kalıp cümleleri kendi sesinizle kişiselleştiriyoruz.

▲ **Dikkat:** Notlandırma kararını YZ'ye bırakmamanızı öneririz. Ad ve numara çıkarılsa bile ödev öğrencinin emeğidir; kurum politikanıza uyun.

4.7 YZ'li ödev tasarımı (süreç odaklı)

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? YZ kullanımını yasaklamak yerine şeffaf ve öğretici kılan, süreci değerlendiren bir ödev tasarlar.

> Rol: Yükseköğretimde ölçme-değerlendirme ve eğitim teknolojileri konusunda deneyimli bir öğretim tasarımcısı olarak çalış.
> Görev: "**[DERS VE KONU]**" için öğrencilerin YZ'yi şeffaf biçimde kullanabileceği, süreç odaklı bir ödev tasarla. Kitle: **[SINIF DÜZEYİ]**. Süre: **[SÜRE]**.
> Ödev şunları içersin:
> 1. Aşamalar ve teslim noktaları (ilk taslak → YZ ile çalışma → eleştirel değerlendirme → son metin).
> 2. Öğrencinin istemlerini ve aldığı yanıtları kaydettiği bir "YZ kullanım günlüğü" şablonu.
> 3. YZ çıktısında en az **[SAYI]** hata veya eksiği bulup güvenilir kaynakla düzeltme görevi.
> 4. Sınıfta kısa sözlü savunma veya geri anlatma bileşeni.
> 5. Değerlendirmede süreç ve ürünün ağırlıkları.
> 6. YZ'nin kullanılamayacağı noktalar (gerçek hasta verisi, kaynak listesi üretme) ve nedenleri.

▸ **İpucu:** YZ'nin hatasını yakalamayı ödüllendiriyoruz. Eğitimdeki kurgusal kaynak listesi (ornekler/05) gibi bir "hata avı" iyi bir başlangıçtır.

▲ **Dikkat:** Ödevin dürüstlüğünü dedektörle değil, süreç kanıtıyla (taslak geçmişi, günlük, sözlü savunma) değerlendiriyoruz. Dedektörler özellikle ana dili İngilizce olmayan yazarlarda yanlış alarm verebilir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

4.8 Zor bir kavram için benzetme ve örnek

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Öğrencilerin zorlandığı bir kavram için benzetmeler, klinik örnekler ve sık yanılgılar üretir.

> Rol: **[BÖLÜM]** öğrencilerine zor kavramları sade anlatmasıyla tanınan bir öğretim üyesi olarak çalış.
> Görev: "**[KAVRAM, ör. sıvı-elektrolit dengesi / Bishop skoru / glisemik indeks ve glisemik yük]**" kavramı için şunları hazırla:
> 1. Günlük hayattan 3 farklı benzetme; her birinin nerede yetersiz kaldığını da yaz.
> 2. Klinikten 2 kısa örnek.
> 3. Öğrencilerin bu konudaki 5 yaygın yanılgısı ve her birini düzelten bir cümle.
> 4. Kavramın anlaşıldığını gösterecek 3 kısa soru.
> Kitle: **[SINIF DÜZEYİ]**. Uzunluk: en fazla 1 sayfa.

▸ **İpucu:** Benzetmenin "nerede yetersiz kaldığı" kısmını derste tartışmak, kavramı benzetmenin kendisinden daha kalıcı öğretir.

▲ **Dikkat:** Benzetmeler basitleştirir. Klinik olarak yanlış bir çağrışım (özellikle doz ve eşik değerlerde) yaratıp yaratmadığını kontrol ediyoruz.

5. Hasta eğitimi ve broşür kişiselleştirme

Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yarısı sağlık bilgisini anlamakta zorlanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2024). **Metin dozu** da ilaç dozu gibi ayarlanır: ilaç dozu hastanın kilosuna ve böbreğine, metin dozu okuryazarlığına göre. Bu eğitimde hasta materyali için hedef **Ateşman ≥70 (kolay)** olarak alınmıştır; bu resmî bir standart değil, bir öğretim önerisidir. Önce 5.1 ile sadeleştiriyoruz, sonra 5.2–5.6'daki profil istemleriyle kişiselleştiriyoruz (hazır giyim yerine terzi dikimi). Güvenli hat: kanıt → YZ taslağı → klinik kontrol → okunabilirlik → hasta testi → onay.

> ■ **Klinik Köşe: Puan tek başına yetmez**
>
> Okunabilirliği Modul4_Okunabilirlik_Hesaplayici.xlsx ile biz ölçüyoruz; YZ'nin söylediği puana güvenmemenizi öneririz. Formül (Ateşman, 1997) yalnızca hece ve cümle uzunluğuna bakar: kısaltmaları "kolay" sayar ve doğruluğu ölçmez. Bu yüzden her hasta metni klinik kontrolden ve geri anlattırmadan (teach-back) geçer.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

5.1 Broşürü sadeleştirme (Ateşman ≥70 hedefli)

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Akademik dille yazılmış bir hasta broşürünü bilgi kaybı olmadan sade, kısa cümleli Türkçeye çevirir.

> Rol: Sağlık okuryazarlığı sınırlı hastalar için yazan deneyimli bir **[ALAN]** eğitim hemşiresi olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki broşür metnini sade Türkçeyle yeniden yaz.
> Amaç: **[HASTA GRUBU, ör. diyabetik ayak riski olan hastalar]** metni tek başına okuyup anlayabilsin ve evde uygulayabilsin.
> Dil kuralları:
> – Kısa cümleler: ortalama 8–10 kelime, hiçbiri 15 kelimeyi geçmesin.
> – Kısa ve günlük kelimeler; gerekli tıbbi terimi bir kez parantez içinde açıkla.
> – Kısaltma kullanma (“KŞ” değil “kan şekeri”).
> – “Siz” diliyle, ne yapılacağını söyleyerek yaz (“Ayağınıza her gün bakın.”).
> – Ara başlıklar ve madde işaretleri kullan.
> Hedef: Ateşman okunabilirlik puanı 70 veya üstü.
> Sınırlar: Bilgi ekleme veya çıkarma; çıkarman gerekirse sonda listele. Sayıları, dozları ve uyarı koşullarını aynen koru. En fazla **[UZUNLUK]**.
> Metin: '''**[BROŞÜR METNİ]**'''

▸ **İpucu:** Eğitimdeki akademik diyabetik ayak broşürü (ornekler/02) 11,6 (çok zor), sade sürümü (ornekler/03) 72,4 (kolay) puan almıştı. Önce ve sonra puanını Excel ile ölçüyoruz.

▲ **Dikkat:** Puan 70'i geçse bile metin doğru olmayabilir. Sadeleştirmede kaybolan veya değişen uyarıları orijinalle satır satır karşılaştırıyoruz.

5.2 Profil 1: Yaşlı, ilkokul mezunu hasta ve yakını

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Sade metni ileri yaşta, okuma alışkanlığı az olan hasta ve onunla okuyacak yakını için uyarlar.

> Aşağıdaki hasta eğitim metnini şu okuyucu için uyarla: **[YAŞ, ör. 72]** yaşında, ilkokul mezunu, okuma alışkanlığı az; metni **[YAKINI, ör. kızı]** ile birlikte okuyacak.
> – Cümle başına en fazla 8–10 kelime; her paragrafta tek fikir.
> – Her adımı numaralı ve “önce–sonra” sırasıyla yaz.
> – Sayıları rakamla yaz (2 kez, 15 dakika); saatleri günlük olaylara bağla (“akşam yemeğinden sonra”).
> – “Yakınınız için” başlıklı kısa bir bölüm ekle: yakının neye dikkat etmesi gerektiği.
> – Büyük puntoyla basılacak; en fazla 1 sayfa.
> Bilgi ekleme; sayıları ve uyarıları aynen koru.
> Metin: '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** Basılı sürümü en az 14 punto ve yüksek kontrastla hazırlıyoruz; resimli adımlar (ör. ayak kontrolü) anlaşılırlığı artırır.

▲ **Dikkat:** “Yaşlı” kalıp yargısıyla çocuksu bir dil oluşabilir. Metnin saygılı, yetişkine hitap eden bir dille yazıldığını kontrol ediyoruz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

5.3 Profil 2: Genç, dijital okur

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Metni akıllı telefondan okuyan genç bir okur için kısa, paylaşılabilir kartlara böler.

> Aşağıdaki hasta eğitim metnini şu okuyucu için uyarla: **[YAŞ ARALIĞI, ör. 20–30]** yaşında, bilgiyi akıllı telefondan arayan, kısa içerik okuyan biri.
> – Metni 5–7 kısa "kart"a böl (her kart: başlık + en fazla 3 cümle).
> – Bir "Kontrol listesi" kartı ve bir "Hemen başvur" kartı mutlaka olsun.
> – Samimi ama doğru ol; argo, emoji ve abartılı ifade kullanma.
> – Bir kartta bu konudaki yaygın bir yanlış inanışı ve doğrusunu ver: **[KONUYA ÖZGÜ YANLIŞ İNANIŞ]**.
> Bilgi ekleme; sayıları ve uyarıları aynen koru.
> Metin: '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** Kurum sitesinde veya sosyal medyada yayımlanacaksa kurumsal iletişim biriminin onayını alıyoruz ve kartlara kurumun resmî bağlantısını ekliyoruz.

▲ **Dikkat:** Kısaltırken koşullu uyarılar ("ateşiniz 38 °C'yi geçerse") sık kaybolur. Her kartı orijinal metinle karşılaştırıyoruz.

5.4 Profil 3: İlk gebelik

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Metni ilk gebeliğini yaşayan kadın ve eşi için sakin, güven veren ama tehlike belirtilerini yumuşatmayan bir dille uyarlar.

> Aşağıdaki metni ilk gebeliğini yaşayan, **[GEBELİK HAFTASI]** haftalık, **[EĞİTİM DÜZEYİ]** bir kadın ve eşi için uyarla.
> – Kaygıyı artırmayan, sakin bir dil kullan; ama tehlike belirtilerini yumuşatma.
> – "Bu normaldir" ve "Bu normal değildir, hemen başvurun" başlıklı iki ayrı bölüm oluştur.
> – Eşin veya destek kişisinin yapabileceklerini ayrı bir kutuda yaz.
> – Tıbbi terimleri (ör. preeklampsi) bir kez, sade açıklamasıyla ver.
> – "Ebenize veya hekiminize sorabileceğiniz 3 soru" ile bitir.
> Bilgi ekleme; sayıları ve uyarıları aynen koru.
> Metin: '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** Gebe okulu materyallerinizle aynı terimleri kullanıyoruz; tutarlı dil kaygıyı azaltır.

▲ **Dikkat:** Gebelikte tehlike belirtileri ve ilaç bilgisi hayati önemdedir. Metni bir ebe veya kadın doğum uzmanı kontrol etmeden dağıtmamanızı öneririz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

5.5 Profil 4: Arapça konuşan hasta (anadil kontrolü zorunlu)

KIRMIZI Yüksek risk, koşullu kullanım **Araç:** genel sohbet asistanı · yalnızca kişisel olmayan metin

Ne işe yarar? Sade Türkçe metnin Arapça taslak çevirisini, anadil konuşanının kontrolüne hazır biçimde üretir.

> Aşağıdaki sade Türkçe hasta eğitim metnini Arapçaya çevir. Okuyucu: **[KÖKEN VE LEHÇE, ör. Suriye kökenli]**, Türkçe okuyamayan, **[EĞİTİM DÜZEYİ]** bir hasta.
> – Modern Standart Arapça kullan ama sade, günlük kelimeler seç; cümleleri kısa tut; madde işaretlerini koru.
> – İlaç adlarını parantez içinde Latin harfleriyle de yaz; sayıları hem Arapça rakamlarla hem 0–9 rakamlarıyla ver.
> – Çeviriden sonra anadil kontrolcüsü için Türkçe bir kontrol tablosu ekle: Türkçe cümle | Arapça çeviri | Çevirirken zorlandığın veya anlamı kayabilecek yer.
> – Kültürel uyarlama gerektirebilecek ifadeleri (ör. beslenme örnekleri) ayrıca listele.
> Metin: '''**[SADE TÜRKÇE METİN]**'''

▸ **İpucu:** Hastanenin tercümanı veya anadili Arapça olan bir sağlık çalışanı metni kontrol etsin; Arapçadan Türkçeye geri çeviri anlam kaymasını yakalamaya yardım eder.

▲ **Dikkat:** YZ çevirisi yalnızca taslaktır; anadil konuşanı ve klinisyen kontrolü olmadan hastaya VERİLMEZ. Doz ve uyarı cümlelerindeki tek kelimelik bir hata ciddi zarar doğurabilir.

5.6 Profil 5: Görme kaybı olan hasta

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Metni ekran okuyucuyla veya sesli dinlenecek biçimde, görsele dayanmadan yeniden düzenler.

> Aşağıdaki hasta eğitim metnini görme kaybı olan bir okuyucu için uyarla. Kullanım: **[KULLANIM, ör. ekran okuyucuyla dinlenecek / sesli kaydedilecek / büyük puntoyla basılacak]**.
> – Görsellere ve tablolara dayanma; "aşağıdaki resimde" gibi ifadeler kullanma.
> – Sesli okunduğunda anlaşılır olsun: kısaltma, simge (°, ≥, /) ve parantez kullanma; "38 derece" gibi yaz.
> – Bölümleri açıkça adlandır ("Birinci bölüm: ..."); adımları sayıyla sırala.
> – Dokunma ve sesle yapılabilecek genel güvenli ipuçları öner (ör. ilaç kutularını lastik bantla ayırt etme) ve bunları **[KONTROL ET]** ile işaretle.
> – Sonda en önemli 3 bilgiyi tekrar et.
> Bilgi ekleme; sayıları ve uyarıları aynen koru.
> Metin: '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** Sesli kaydı hastaya dinletip birkaç soru soruyoruz. İnsülin kalemi gibi cihazlar için dokunarak, uygulamalı öğretim planlıyoruz.

▲ **Dikkat:** Görme kaybı olan hastada ilaç hazırlama güvenliği ayrıca değerlendirilmelidir; metin, uygulamalı eğitimin yerini tutmaz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

5.7 “Ne zaman acile gelinir?” kutusu

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Bir hasta metninden, yalnızca metindeki bilgilere dayanan üç düzeyli acil başvuru kutusu hazırlar.

> Görev: Aşağıdaki hasta eğitim metninden YALNIZCA metindeki bilgilere dayanarak bir “Ne zaman acile gelinir?” kutusu hazırla.
> Biçim:
> – Üç bölüm: “Hemen 112'yi arayın” | “Bugün acile gelin” | “Birkaç gün içinde polikliniğe başvurun”.
> – Her madde ölçülebilir bir belirtiyle başlasın (“Ateşiniz 38 dereceyi geçerse”).
> – Her maddenin yanına metindeki dayanağını parantez içinde göster.
> – Her bölüm en fazla 5 madde; cümleler en fazla 10 kelime.
> Sınırlar: Metinde olmayan belirti veya eşik değer EKLEME. Gerekli olduğunu düşündüğün ek maddeleri kutunun dışında, “**[KONTROL ET]** Klinisyene önerilen ek maddeler” başlığıyla ayrıca yaz.
> Metin: '''**[HASTA EĞİTİM METNİ VEYA TABURCULUK TALİMATI]**'''

▸ **İpucu:** Sentetik epikrizdeki (ornekler/01) acil başvuru kriterleri (ateş >38 °C; yarada kızarıklık, şişlik veya koku; kan şekeri >300 mg/dL) kutuda eksiksiz ve aynı eşiklerle yer aldı mı?

▲ **Dikkat:** Eşik değerler kuruma ve hastaya göre değişir. Kutudaki her eşik ve 112 / acil / poliklinik ayrımı sorumlu klinisyen tarafından onaylanmalıdır.

5.8 Teach-back (geri anlattırma) soruları

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Hastanın anladığını kendi sözleriyle anlatmasını veya göstermesini sağlayacak açık uçlu sorular üretir.

> Rol: Geri anlattırma (teach-back) yöntemini kullanan deneyimli bir eğitim hemşiresi veya ebe olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki hasta eğitim metni için teach-back soruları hazırla. Hasta: **[HASTA PROFİLİ]**.
> Kurallar:
> – “Anladınız mı?” gibi evet/hayır sorusu YOK. Her soru hastanın kendi sözleriyle anlatmasını veya göstermesini istesin (“Eve gidince insülininizi nasıl yapacağınızı bana gösterir misiniz?”).
> – Sorular suçlamayan bir girişle başlasın (“Size iyi anlatabildim mi, emin olmak istiyorum.”).
> – Metindeki en kritik 5 konu için birer soru yaz.
> – Her soru için: beklenen doğru yanıt + yanıt eksikse yeniden anlatırken vurgulanacak nokta.
> Metin: '''**[HASTA EĞİTİM METNİ]**'''

▸ **İpucu:** Döngüyü uyguluyoruz: anlat → geri anlattır → eksikse yeniden anlat → yeniden sor (Şekil 4.8). Soruları ikili rol oyunuyla deneyin.

▲ **Dikkat:** Teach-back bir sınav değildir; hastayı değil, eğitimin yeterliliğini ölçer. “Beklenen yanıtlar” metindeki bilgiyle birebir uyuşmalı.

Prof. Dr. AKDAĞLI

5.9 Sık sorulan sorular (SSS)

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Bir hasta metninden, hastanın ağzından sorular ve yalnızca metne dayanan kısa yanıtlar hazırlar.

> Rol: **[ORTAM, ör. diyabet polikliniği]** hemşiresi olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki hasta eğitim metnine dayanarak hastaların ve yakınlarının sık sorabileceği **[SAYI, ör. 10]** soruyu ve yanıtlarını yaz.
> Kurallar:
> – Soruları hastanın ağzından, günlük dille yaz (“Ayağımda küçük bir yara var, kendim pansuman yapabilir miyim?”).
> – Yanıtlar en fazla 3 kısa cümle olsun ve yalnızca metindeki bilgiye dayansın.
> – Metinde yanıtı olmayan önemli bir soru varsa yanıt uydurma; “**[METİNDE YOK]** Bu soruyu hemşirenize veya hekiminize sorun.” yaz.
> – Sonda, metinde yanıtı olmayan soruları klinisyenin eklemesi için ayrıca listele.
> Metin: '''**[HASTA EĞİTİM METNİ]**'''

▸ **İpucu:** Poliklinikte gerçekten sorulan soruları (kimlik bilgisi olmadan) not alıp isteme ekliyoruz; SSS çok daha gerçekçi olur.

▲ **Dikkat:** YZ, metinde olmayan genel bilgiyi “kendinden” ekleme eğilimindedir. Yanıtları metinle satır satır karşılaştırıyoruz.

5.10 Beslenme planını sade dile çevirme

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı · yalnızca anonim plan

Ne işe yarar? Diyetisyenin teknik beslenme planını hastanın günlük hayatına uyan, ev ölçüleriyle yazılmış bir rehbere dönüştürür.

> Rol: Klinik beslenmede deneyimli, hastalarla sade dille konuşan bir diyetisyen olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki teknik beslenme planını hastanın anlayacağı sade bir rehbere dönüştür.
> Hasta: **[PROFİL, ör. 55 yaşında, tip 2 diyabetli, ortaokul mezunu, evde yemek yiyen; yasaklayıcı dil kaygısını artırıyor]**.
> Biçim:
> 1. “Bir günüm” tablosu: Öğün | Ne yiyebilirim (ev ölçüsüyle: su bardağı, yemek kaşığı, avuç) | Örnek.
> 2. Değişim listesi: bir besin yerine ne yenebilir (yalnızca plandaki değişimleri kullan).
> 3. Etiket okuma ve dışarıda yemek için 3'er kısa ipucu.
> Kurallar: Plandaki enerji, karbonhidrat ve porsiyon miktarlarını DEĞİŞTİRME. Gramı ev ölçüsüne çevirirken emin olmadığın dönüşümü **[KONTROL ET]** ile işaretle. Yeni besin, takviye veya ürün önerme.
> Plan (anonim): '''**[BESLENME PLANI]**'''

▸ **İpucu:** Ev ölçüsü dönüşümlerini kurumunuzun standart porsiyon ve değişim listesiyle karşılaştırıyoruz; yöresel yemek örneklerini (bulgur pilavı, mercimek çorbası) isteme ekliyoruz.

▲ **Dikkat:** Gram–ev ölçüsü dönüşümleri sık hata yapılan yerlerdir. Böbrek hastalığı, gebelik veya insülin kullanımında planın her satırını diyetisyen onaylamalıdır.

Prof. Dr. Bilal AKDAĞLI

6. Klinik dokümantasyon (yalnızca kurum onaylı araçla)

Epikriz ve taburculuk metinleri en büyük zaman kazancının, ama aynı zamanda en büyük riskin olduğu alandır. YZ burada stajyer gibidir: notu yazar, **sorumlu hemşire veya hekim okur, düzeltir ve imzalar**. Zaretsky ve ark. (2024) çalışmasında YZ ile hasta diline çevrilen taburculuk özetlerinin okunabilirliği ve anlaşılırlığı belirgin biçimde artmış, ancak hekim değerlendirmelerinin **%18'inde güvenlik endişesi** bildirilmiştir; endişeler çoğunlukla eksik bilgi, bazen de yanlış ifadeydi.

■ Bu bölüm için kesin kural

- Bu bölümdeki istemler **YALNIZCA kurumunuzun onayladığı, sözleşmeli YZ aracında** kullanılır. Kurumunuzda böyle bir araç yoksa yalnızca **sentetik veya kurgusal** metinle (eğitimde: ornekler/01_sentetik_epikriz.txt) çalışıyoruz.
- Genel, ücretsiz bir sohbet botuna epikriz, hemşire notu, laboratuvar sonucu veya hasta fotoğrafı **yapıştırmıyoruz**. Sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir; üretken YZ'de kişisel veri işleniyorsa 6698 sayılı Kanun uygulanır (KVKK, 2025).
- Ad silmek anonimleştirme değildir: tarih, protokol no, nadir tanı ve yer birleşimi de kişiyi belirleyebilir (bkz. 7.4).
- Hiçbir çıktı imzasız ve kontrolsüz hastaya verilmez veya kayda girmez.

6.1 Epikrizden taburculuk eğitim metni (ilaç tablosu + “dosyada yoksa yazma”)

KIRMIZI Yüksek risk, koşullu kullanım **Araç:** YALNIZCA kurum onaylı araç · anonim/sentetik veri

Ne işe yarar? Bir epikrizden hasta ve yakını için ilaç tablolu, sade bir taburculuk eğitim metni taslağı hazırlar.

Rol: Taburculuk eğitimi veren deneyimli bir **[SERVİS]** hemşiresi olarak çalış.
Görev: Aşağıdaki epikrizden hasta ve yakını için taburculuk eğitim metni TASLAĞI hazırla.
Hasta profili: **[YAŞ, EĞİTİM, BAKIM VEREN, ör. 68 yaşında, ilkokul mezunu, kızıyla yaşıyor]**.
Konular: **[KONULAR, ör. evde insülin, kan şekeri ölçümü, hipoglisemi, ayak bakımı, antibiyotik, kontrol randevuları]**.
TEMEL KURAL: Yalnızca epikrizde yazan bilgiyi kullan. Epikrizde olmayan hiçbir ilaç, doz, saat, süre, eşik değer veya randevu yazma. Gerekli olduğunu düşündüğün ama epikrizde olmayan bilginin yerine **[DOSYADA YOK]** yaz.
Biçim:
1. İlaç tablosu: İlaç | Ne için | Ne kadar | Ne zaman | Kaç gün | Dikkat | Epikrizdeki yeri. Epikrizdeki her taburculuk ilacı tabloda olmalı.
2. Konu başlıklarıyla sade anlatım: kısa cümleler, “siz” dili, kısaltma yok.
3. “Ne zaman acile gelinir?” kutusu (yalnızca epikrizdeki kriterlerle).
4. Kontrol randevuları.
5. Sonda “Klinisyen kontrolü için” listesi: tüm **[DOSYADA YOK]** yerleri ve epikrizde belirsiz bulduğun ifadeler.
Epikriz (anonim/sentetik): '''**[EPİKRİZ METNİ]**'''

▸ **İpucu:** Sentetik epikrizle hata avı yapıyoruz: glarjin 18 Ü saat 22:00; aspart 6-6-6 Ü; antibiyotiğin 7 gün daha sürmesi; hipoglisemi eşiği (<70 mg/dL, 15 g karbonhidrat, 15 dakika sonra yeniden ölçüm); acil başvuru kriterleri ve kontrol randevuları doğru mu? Eksik, yanlış veya eklenmiş bilgi var mı?

▲ **Dikkat:** Metin, sorumlu hemşire veya hekim epikrizle satır satır karşılaştırıp imzalamadan hastaya verilmez. İlaç tablosundaki her satırı tek tek kontrol ediyoruz.

Prof. Dr. AKDAĞLI

6.2 Taburculuk metnini epikrizle karşılaştırma (hata avı)

KIRMIZI Yüksek risk, koşullu kullanım **Araç:** YALNIZCA kurum onaylı araç · anonim/sentetik veri

Ne işe yarar? Bir taburculuk metni taslağını kaynak epikrizle karşılaştırıp eksik, yanlış ve eklenmiş bilgiyi listeler.

> Görev: Aşağıdaki iki metni karşılaştır: (A) kaynak epikriz, (B) hastaya verilecek taburculuk metni taslağı. Hiçbir metni yeniden yazma.
> Biçim: Tablo: No | Bulgu türü | B'deki ifade | A'daki ilgili ifade | Hasta güvenliği açısından önem (yüksek / orta / düşük).
> Bulgu türleri: **[EKSİK]** A'da var, B'de yok · YANLIŞ: B, A'dan farklı · EKLENMİŞ: B'de var, A'da yok · **[ÇELİŞKİ]** veya belirsiz ifade.
> Özellikle kontrol et: ilaç adları, dozlar, uygulama saatleri, tedavi süreleri, eşik değerler (kan şekeri, ateş), uyarı belirtileri, kontrol randevuları.
> Sonda yüksek önemdeki bulguların sayısını yaz.
> (A) Epikriz: '''**[EPİKRİZ]**'''
> (B) Taslak: '''**[TABURCULUK METNİ TASLAĞI]**'''

▸ **İpucu:** Bu istemi taslağı üreten sohbetten AYRI, yeni bir sohbette çalıştırıyoruz; aynı sohbette model kendi yazdığına bağlı kalabilir.

▲ **Dikkat:** Karşılaştırma da hata kaçırabilir. "Bulgu yok" yanıtı güvenlik onayı değildir; ilaç tablosunu biz de satır satır kontrol ediyoruz.

6.3 SBAR devir notu yapılandırma

KIRMIZI Yüksek risk, koşullu kullanım **Araç:** YALNIZCA kurum onaylı araç · anonim/sentetik veri

Ne işe yarar? Dağınık vardiya notlarını SBAR (Durum, Öykü, Değerlendirme, Öneri) yapısında bir devir notu taslağına dönüştürür.

> Rol: Hasta devir tesliminde SBAR kullanan deneyimli bir sorumlu hemşire olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki anonim vardiya notlarını SBAR yapısında bir devir notu taslağına dönüştür.
> Biçim: S – Durum | B – Öykü | A – Değerlendirme | R – Öneri. Her bölüm en fazla 4 madde.
> Kurallar:
> – Yalnızca notlardaki bilgiyi kullan; yorum, tanı veya tedavi önerisi ekleme. "Öneri" bölümünde yalnızca notlarda yazan planları ve bekleyen işleri listele.
> – Yaşam bulgularını ve saatlerini aynen aktar.
> – Notlarda çelişen veya eksik bilgi varsa **[ÇELİŞKİ]** ya da **[EKSİK]** ile işaretle.
> – Ad, protokol no, oda no yazma; hastayı "Hasta A" diye an.
> Notlar (anonim/sentetik): '''**[VARDİYA NOTLARI]**'''

▸ **İpucu:** SBAR öğretirken kurgusal notlarla kullanıyoruz: öğrencinin yazdığı SBAR ile YZ'ninkini karşılaştırmak iyi bir tartışma başlatır.

▲ **Dikkat:** Yazılı SBAR sözlü devir teslimin yerine geçmez. YZ'nin "Değerlendirme" bölümüne notlarda olmayan klinik çıkarım eklemediğinden emin oluyoruz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

6.4 Taburculuk kontrol listesi

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı (hasta verisi gerektirmez)

Ne işe yarar? Belirli bir hasta grubu için, hasta verisi kullanmadan, taburculuk öncesi kontrol listesi taslağı hazırlar.

> Rol: Taburculuk planlamasında deneyimli bir klinik hemşire eğitimcisi olarak çalış.
> Görev: "**[HASTA GRUBU, ör. yeni insülin başlanan ve diyabetik ayak yarası olan yetişkinler]**" için taburculuk öncesi kontrol listesi taslağı hazırla.
> Biçim: Tablo: Alan | Kontrol maddesi | Evet / Hayır / Uygulanmaz | Sorumlu (hemşire / hekim / diyetisyen / eczacı / sosyal hizmet).
> Alanlar: ilaçlar ve ilaç uzlaştırma; cihaz ve beceri eğitimi (gösterip geri yaptırma); uyarı belirtileri; beslenme; yara bakımı; randevular ve sevkler; evde bakım ve destek; eğitim materyalinin verilmesi ve teach-back.
> Kurallar: Her madde gözlenebilir ve tek eylemli olsun. Kuruma göre değişebilecek maddeleri **[KURUM PROTOKOLÜ]** ile işaretle. Hasta bilgisi kullanma; genel bir liste olsun.

▸ **İpucu:** Listeyi kurumunuzun mevcut taburculuk formuyla karşılaştırıyoruz; eksik maddeleri formun güncellenmesi için kalite birimine öneriyoruz.

▲ **Dikkat:** Hasta verisi içermediği için genel bir araçta hazırlanabilir; ancak klinikte kullanılmadan önce kurum protokolüne uyarlanmalı ve onaylanmalıdır.

6.5 Kendi taslağınızı hata için denetletme

KIRMIZI Yüksek risk, koşullu kullanım **Araç:** YALNIZCA kurum onaylı araç · anonim/sentetik veri

Ne işe yarar? Kendi yazdığınız anonim bir klinik veya eğitim metnini güvenlik ve tutarlılık hataları için ikinci göz olarak tarar.

> Rol: Hasta güvenliği konusunda titiz bir kalite hemşiresi olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki **[METİN TÜRÜ, ör. taburculuk eğitim notu / hasta bilgilendirme formu / bakım planı]** taslağımı hatalar için denetle. Metni yeniden yazma.
> Kontrol et:
> 1. İç tutarlılık: aynı ilacın, dozun veya saatin farklı yerlerde farklı yazılması.
> 2. Ölçülemeyen talimatlar: "gerekirse", "bol su için", "bir süre" gibi.
> 3. Karışabilecek kısaltma ve yazımlar (Ü / U, mg / mcg, ondalık ve sıfır kullanımı).
> 4. Eksik olabilecek güvenlik bilgisi (uyarı belirtileri, kime başvurulacağı). Eklenmesini yalnızca öner; doğru değeri uydurma.
> Biçim: Tablo: Konum | Sorun | Neden riskli | Öneri | Önem.
> Taslak (anonim): '''**[TASLAĞINIZ]**'''

▸ **İpucu:** Kurumunuzun "kullanılmayacak kısaltmalar" listesini isteme ekliyoruz; denetim kurum diline uyar.

▲ **Dikkat:** YZ'nin bulamadığı hata yok demek değildir. İlaç ve doz kararları her zaman klinisyenindir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

6.6 Epikriz kısaltmalarını açma ve sade karşılık bulma

KIRMIZI Yüksek risk, koşullu kullanım **Araç:** YALNIZCA kurum onaylı araç · anonim/sentetik veri

Ne işe yarar? Bir epikrizdeki kısaltma ve terimleri listeler, açık hâllerini ve hastaya söylenebilecek sade karşılıklarını önerir.

> Görev: Aşağıdaki anonim/sentetik epikrizdeki tüm kısaltmaları ve tıbbi terimleri listele.
> Biçim: Tablo: Kısaltma/terim | Açık hâli | Hastaya söylenebilecek sade karşılık (en fazla 8 kelime) | Emin misin?
> Kurallar:
> – Bağlama göre birden fazla anlama gelebilen kısaltmalarda tüm olasılıkları yaz ve **[KONTROL ET]** ile işaretle; tahminle tek anlam seçme.
> – Metinde olmayan kısaltma ekleme.
> Epikriz (anonim/sentetik): '''**[EPİKRİZ METNİ]**'''

▸ **İpucu:** Sentetik epikrizin "Seyir" bölümü Ateşman'da 67,9 (orta) çıkar; çünkü formül "KŞ", "DM", "p.o." gibi kısaltmaları kısa ve kolay kelime sayar. Kısaltmalar açılınca gerçek güçlük görünür.

▲ **Dikkat:** Kısaltmaların anlamı servise ve kuruma göre değişebilir. Tablo klinisyen kontrolünden geçmeden hasta metnine aktarılmaz.

7. Doğrulama ve güvenlik istemleri

Bu bölümdeki istemler yeni içerik üretmez; **üretilmiş içeriği denetler**. Çoğunu diğer istemlerin sonuna ekleyebilir ya da çıktıyı aldıktan sonra ayrı bir adım olarak çalıştırabilirsiniz. Halüsinasyon konfabulasyona benzer: model yalan söylemez, boşluğu inandırıcı bir uydurmayla doldurur. Bu istemler o boşlukları görünür kılar; ama doğrulamayı yine siz yaparsınız.

7.1 "Bu metindeki her iddiayı listele ve kaynak gerekenleri işaretle"

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Bir metindeki tüm olgusal iddiaları ayıklar ve kaynak gerektirenleri işaretler; kontrol haritası çıkarır.

> Görev: Aşağıdaki metindeki her olgusal iddiayı (sayı, oran, neden-sonuç ilişkisi, tanım, öneri) ayrı bir satırda listele.
> Biçim: Tablo: No | İddia (metindeki ifadeyle) | Tür (sayısal / nedensel / tanım / öneri / genel bilgi) | Kaynak gerekli mi? | Metinde kaynak gösterilmiş mi? | Risk notu.
> Kurallar:
> – Kaynak ÖNERME, kaynak adı yazma; yalnızca kaynak ihtiyacını işaretle.
> – Genelleyici ifadeleri ("her zaman", "kanıtlanmıştır", "tüm hastalarda") ayrıca işaretle.
> Metin: '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** YZ'nin yazdığı her taslağı bu istemle "ters yüz edin": çıkan liste, kontrol etmeniz gereken yerlerin haritasıdır.

▲ **Dikkat:** Liste eksik olabilir; özellikle cümle içine gömülü sayılar atlanabilir. Kritik metinlerde iddiaları kendimiz de işaretliyoruz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

7.2 “Emin olmadığın yerleri [KONTROL ET] ile işaretle”

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı (her istemin sonuna eklenebilir)

Ne işe yarar? YZ'den belirsizliğini görünür kılmasını ister; kontrol önceliğini belirlemeyi kolaylaştırır.

> Bu görevde şu kurala uy: Bir bilgiden tam emin değilsen, o bilgiyi yazdıktan hemen sonra **[KONTROL ET]** etiketi koy.
> Bilginin güncelliğinden emin değilsen **[KONTROL ET: güncellik]** yaz.
> Hiç bilmiyorsan tahmin yürütme; “Bu bilgiye sahip değilim.” yaz.
> Yanıtının sonunda tüm **[KONTROL ET]** etiketlerini bir listede topla ve her birinin hangi tür kaynakla doğrulanabileceğini yaz (ör. güncel klinik rehber, ilaç prospektüsü, birincil makale). Kaynak adı uydurma.
> Görev: **[ASIL GÖREVİNİZ]**

▸ **İpucu:** Bu paragrafı bir kez kaydediyoruz ve önemli her istemin sonuna yapıştırıyoruz.

▲ **Dikkat:** Etiketsiz yer “doğru” demek değildir: model en tehlikeli hatalarını emin bir sesle yapar (yanlış ama emin = halüsinasyon, Şekil 1.7). Etiketler yalnızca öncelik sırasını gösterir.

7.3 “Yanıtındaki varsayımları listele”

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? YZ'nin sessizce yaptığı varsayımları (kitle, ülke, rehber sürümü) ortaya çıkarır ve onayınıza sunar.

> Önceki yanıtını üretirken yaptığın varsayımları listele.
> Biçim: Tablo: Varsayım | Yanıtın hangi kısmını etkiledi | Varsayım yanlışsa ne değişir | Bana sorman gereken soru.
> Özellikle şunları düşün: hedef kitle, kullanım ortamı, ülke ve kurum uygulamaları, güncel rehber sürümü, hastanın özellikleri, istemimde belirsiz bıraktığım noktalar.
> Sonra en kritik 3 varsayımı onayıma sun; onaylamadığım varsayımlara göre yanıtını güncelle.

▸ **İpucu:** Ülke farkı sık gözden kaçan bir varsayımdır: YZ başka ülkenin acil numarasıyla, ilaç ticari adıyla veya ölçü birimiyle (ör. mmol/L) yazabilir.

▲ **Dikkat:** YZ her varsayımının farkında olmayabilir. Liste, sizin kontrolünüzün yerini değil başlangıç noktasını oluşturur.

7.4 Anonimleştirme kontrol istemi

KIRMIZI Yüksek risk, koşullu kullanım **Araç:** YALNIZCA kurum onaylı araç · anonim/sentetik veri veya önceden anonimleştirilmiş/sentetik metin

Ne işe yarar? Önceden anonimleştirdiğiniz bir metinde kimlik belirleyebilecek kalıntıları ikinci göz olarak arar.

> Görev: Aşağıdaki metinde bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek bilgileri bul. Metni yeniden yazma.
> Ara:
> – Ad-soyad ve baş harfler; T.C. kimlik, protokol, dosya, oda ve yatak numarası.
> – Telefon, adres, e-posta; doğum tarihi; yatış ve taburculuk tarihleri.
> – Meslek, işyeri, akrabalık bilgisi.
> – Nadir tanı, nadir olay ve yer bilgisinin birleşimi; fotoğraf veya belge açıklamaları.
> Biçim: Tablo: Konum | İfade | Tanımlayıcı türü (doğrudan / dolaylı) | Risk (yüksek / orta / düşük) | Öneri (sil / genelleştir; ör. “68 yaşında” → “60'lı yaşlarında”, tarih → “yatışın 3. günü”).
> Metin (önceden anonimleştirilmiş veya sentetik): '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** Gerçek metni hiç yapıştırmadan da yararlanabilirsiniz: “Hemşirelik notlarında kimlik belirleyebilecek bilgi türlerinin kontrol listesini hazırla.” örneğin ve listeyi elle uyguluyoruz (Şekil 4.7).

▲ **Dikkat:** Kimlik bilgisi içeren bir metni “anonimleştirsin” diye genel bir sohbet botuna yapıştırmak, verinin kendisini paylaşmak demektir. Önce biz anonimleştiriyoruz; bu istem yalnızca ikinci göz içindir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

7.5 Kaynak listesini doğrulama tablosuna dönüştürme

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Bir kaynak listesini, veritabanında sizin kontrol edeceğiniz alan alan bir doğrulama tablosuna çevirir.

> Aşağıdaki kaynak listesini bir doğrulama tablosuna dönüştür. Kaynakların gerçek olup olmadığına KARAR VERME; kontrolü ben yapacağım.
> Tablo: No | Yazar(lar) | Yıl | Başlık | Dergi | Cilt(sayı):sayfa | DOI | Eksik alan var mı? | Şüphe işareti (DOI yok, sayfa aralığı tuhaf, başlıkta çarpıcı bir sayı, dergi-konu uyumsuzluğu vb.).
> Tablonun altına her kaynak için benim dolduracağım boş sütunlar ekle: Veritabanında bulundu mu? | Bilgiler eşleşiyor mu? | Metindeki iddiayı destekliyor mu?
> Liste: '''**[KAYNAK LİSTESİ]**'''

▸ **İpucu:** Kaynak doğrulama, ilaç uygulamasındaki "doğrular" gibidir: doğru yazar, yıl, dergi, cilt-sayfa, DOI ve iddia (Şekil 2.5). Kurgusal kaynak avcılığı listesiyle (ornekler/05) deneyin.

▲ **Dikkat:** YZ'ye "Bu kaynaklar gerçek mi?" diye sormak çözüm değildir; uydurma bir kaynağı da onaylayabilir. Her DOI'yi doi.org'da, her makaleyi PubMed veya Google Scholar'da açıyoruz.

7.6 Sayı ve istatistik eşleştirme

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Bir özetteki veya sunumdaki her sayıyı kaynak metindeki karşılığıyla eşleştirir; bağlam kaymalarını yakalar.

> Aşağıda (A) kaynak metin ve (B) ondan üretilmiş bir özet var.
> Görev: B'deki her sayıyı (n, %, ortalama, SS, fark, GA, p, süre, doz) A'daki karşılığıyla eşleştir.
> Tablo: B'deki sayı ve bağlamı | A'daki karşılığı (aynen) | A'daki yeri | Durum (aynı / farklı / A'da yok / yuvarlanmış / bağlamı değişmiş).
> Bağlam kaymasına özellikle dikkat et: aynı sayının farklı gruba, zamana veya sonuca atfedilmesi (ör. randomize edilen n ile analize alınan n'nin karışması).
> (A): '''**[KAYNAK METİN]**'''
> (B): '''**[ÖZET VEYA SUNUM METNİ]**'''

▸ **İpucu:** Kurgusal RKÇ'de 120 kişi randomize edilmiş, 108 kişi tamamlamıştır; p=0,002 öz yeterliliğe, p=0,18 ilaç uyumuna aittir. Bu sayıların yer değiştirip değiştirmediğine bakıyoruz.

▲ **Dikkat:** YZ bir sayıyı "aynı" diye işaretleyip bağlam değişimini kaçırabilir. Birincil sonuç sayılarını her zaman kendimiz kontrol ediyoruz.

7.7 Uzman gözüyle öz eleştiri

YEŞİL Düşük risk **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? YZ'nin kendi yanıtını belirli bir uzman gözüyle eleştirmesini ve düzeltilmiş sürüm yazmasını sağlar.

> Önceki yanıtını bağımsız ve eleştirel bir **[UZMAN TÜRÜ, ör. klinik hemşirelik öğretim üyesi / sağlık okuryazarlığı uzmanı]** gözüyle değerlendir:
> 1. Olgusal olarak yanlış veya güncel olmayabilecek ifadeler.
> 2. Eksik bırakılan önemli konular.
> 3. Hedef kitle (**[KİTLE]**) için uygun olmayan dil veya ton.
> 4. Hasta güvenliği açısından riskli olabilecek ifadeler.
> Her madde için ilgili cümleyi alıntıla ve düzeltme öner. Ardından düzeltilmiş sürümü yaz ve neyi değiştirdiğini listele.

▸ **İpucu:** Öz eleştiriyi farklı bir araçta yaptırmak (bir asistanın çıktısını başka bir asistana vermek) farklı hataları yakalamaya yardım edebilir.

▲ **Dikkat:** Aynı model kendi hatasını görmeyebilir ya da doğruyu "düzeltirken" bozabilir. Son karar ve sorumluluk sizindir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

7.8 Hasta metni güvenlik taraması

SARI Doğruluyoruz, gerekirse beyan ediyoruz **Araç:** genel sohbet asistanı

Ne işe yarar? Hastaya verilecek bir metinde zarar doğurabilecek ifadeleri işaretler.

> Rol: Hasta güvenliği ve sağlık iletişimi konusunda deneyimli bir klinisyen olarak çalış.
> Görev: Aşağıdaki hasta metnini zarar doğurabilecek ifadeler için tara. Metni yeniden yazma. Hasta grubu: **[HASTA GRUBU]**.
> Ara:
> – Yanlış anlaşılırsa doz hatasına yol açabilecek ifadeler.
> – Hastayı acil başvurudan alıkoyabilecek yatıştırıcı ifadeler (“genellikle önemli değildir”).
> – Hekime danışmadan ilacı bırakma veya değiştirme izlenimi veren ifadeler.
> – Kesin vaat (“tamamen iyileşirsiniz”) veya korkutucu dil.
> – Bitkisel ürün, takviye veya “doğal tedavi” önerileri.
> – Bu hasta grubuna uymayabilecek genel öneriler (ör. böbrek hastasına “bol su için”).
> Biçim: Tablo: Konum | İfade | Olası zarar | Düzeltme yönü | Önem.
> Metin: '''**[HASTA METNİ]**'''

▸ **İpucu:** Bu taramayı broşür üretim hattında klinik kontrol adımından hemen önce kullanıyoruz.

▲ **Dikkat:** Tarama klinik kontrolün yerine geçmez; yalnızca dikkatinizi riskli yerlere yönlendirir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

8. Kendi istem kütüphanenizi kuruyoruz

En iyi istem, sizin işinize göre uyarlanmış ve birkaç kez denenmiş istemdir. Bu kitapçıktaki kartları başlangıç noktası olarak kullanıyoruz; işe yarayanları aşağıdaki boş kartla kendi dosyanıza (Word, OneNote veya bir not uygulaması) kaydediyoruz. Kart biçimini korumak, bir yıl sonra açtığınızda istemin neden ve nasıl yazıldığını hatırlamanızı sağlar.

Boş kart şablonu

Başlık: _____ Kategori: _____

Etiket: ☐ YEŞİL ☐ SARI ☐ KIRMIZI **Araç:** _____

Ne işe yarar? _____

> Rol: Sen bir **[ROL]** olarak çalışıyorsun.
> Görev: **[YAPILACAK İŞ]**
> Amaç: **[BU ÇIKTI NE İÇİN KULLANILACAK]**
> Kitle ve bağlam: **[KİM OKUYACAK, NEREDE KULLANILACAK]**
> Biçim: **[TABLO / MADDE / UZUNLUK / DİL DÜZEYİ]**
> Sınırlar: **[YAPMAMASI GEREKENLER]**. Emin olmadığın bilgiyi **[KONTROL ET]** ile işaretle. Kaynak gereken yere **[KAYNAK]** koy.
> Metin: '''**[METİN]**'''

▸ **İpucu:** _____

▲ **Dikkat:** _____

Denendi: (tarih, araç, kaç kez, sonuç) _____

İstem kayıt tablosu

Kütüphaneniz büyüdükçe bir dizin tutuyoruz. Araçlar değiştiğinde hangi istemlerin yeniden denenmesi gerektiğini bu tablodan görürsünüz.

No	İstem adı	Etiket	Araç	Son deneme	Sürüm	Not

Kütüphanenizi büyütürken

- **Bir istemi üç kez deneyin** (farklı gün veya farklı araç). Her seferinde iyi sonuç veriyorsa kaydediyoruz.
- **Sürüm tutuyoruz.** İstemi değiştirdiğinizde eski sürümü silmemenizi öneririz; neyi neden değiştirdiğinizi “Not” sütununa yazıyoruz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

- **Eğitimdeki sentetik örneklerle test ediyoruz.** Sentetik epikriz, kurgusal RKÇ özeti ve diyabetik ayak broşürü, doğru yanıtını bildiğiniz test metinleridir; yeni bir istemi önce onlarla sınıyoruz.
- **Meslektaşlarınızla paylaşıyoruz.** Bölüm içinde ortak bir istem dosyası, aynı hatanın tekrarlanmasını önler. Paylaşılan istemlerde hiçbir gerçek veri veya örnek hasta metni bulunmamalıdır.
- **Etiketi dürüst koyuyoruz.** Hasta veya öğrenci verisine dokunan her istem en az SARI, kişisel veri gerektiren her istem KIRMIZIdır.

Kaynakça

Bu kitapçıkta atıf yapılan kaynaklar (Vancouver). Tam liste Modül 4 ders notundadır.

1. Walters WH, Wilder EI. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Sci Rep. 2023;13(1):14045. doi:10.1038/s41598-023-41032-5
2. International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals [Internet]. Updated January 2026. Available from: https://www.icmje.org/recommendations/
3. Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber. Ankara: YÖK; 2024 Mayıs.
4. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Üretken Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi (15 Soruda). Ankara: KVKK; 2025 Kasım.
5. Gallifant J, Afshar M, Ameen S, et al. The TRIPOD-LLM reporting guideline for studies using large language models. Nat Med. 2025;31(1):60-9. doi:10.1038/s41591-024-03425-5
6. Zaretsky J, Kim JM, Baskharoun S, et al. Generative artificial intelligence to transform inpatient discharge summaries to patient-friendly language and format. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e240357. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.0357
7. Ateşman E. Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi. 1997;(58):71-4.
8. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması. Yayın No: 1298. Ankara; 2024.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI